



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Εμπειρίες ασθενών στην διάγνωση και την αντιμετώπιση της ΔΑΕ»

Κάκου Σωτηρία - Λογοθεραπεύτρια

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Ηλιάδου Βασιλική-Μαρία

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Παρασκευή Τατσιοπούλου

Doris Eva Bamiou

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

Περίληψη

Υπόβαθρο: Η Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) επηρεάζει την ικανότητα των ατόμων να κατανοούν και να επεξεργάζονται ηχητικές πληροφορίες παρόλο που έχουν φυσιολογική ακουστική οξύτητα. Η διαγνωστική εξέταση της ΔΑΕ βασίζεται σε μια σειρά εξειδικευμένων ακουστικών και γνωστικών δοκιμασιών, καθώς και σε κλινικές αξιολογήσεις, δεδομένου ότι δε μπορεί να ανιχνευθεί μέσω τυπικών ακοομετρικών εξετάσεων. Η ΔΑΕ μπορεί να προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή ζωή, ειδικά σε περιβάλλοντα με πολλούς θορύβους, ή όταν υπάρχουν πολλαπλές πηγές ομιλίας. Παρότι υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαταραχή, οι εμπειρίες των ατόμων με ΔΑΕ, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης και αποκατάστασης, δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς.

Στόχος: Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τις εμπειρίες ατόμων με ΔΑΕ σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και ο εργασιακός χώρος. Ειδικότερα, η μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής εξέτασης και της αποκατάστασης, καθώς και στη διερεύνηση των θετικών και αρνητικών εμπειριών τους.

Μεθοδολογία: Η μελέτη χρησιμοποίησε τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης για την επεξεργασία δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια απευθύνονταν σε άτομα που ολοκλήρωσαν την διαγνωστική εξέταση της ΔΑΕ και διαγνώστηκαν με ΔΑΕ ή είχαν φυσιολογική ακουστική επεξεργασία. Εστίασαν στις εμπειρίες τους με επαγγελματίες υγείας,

εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες, καθώς και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν σε καθημερινές καταστάσεις.

Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν πως το 82,5% από το σύνολο των 40 συμμετεχόντων διέθετε κάποια πρόσθετη διάγνωση πριν την αξιολόγηση για ΔΑΕ ενώ το 67,5% διαγνώστηκε και με ΔΑΕ. Το 90% των ατόμων απευθύνθηκε σε κάποιον ειδικό μέσα στους πρώτους 6 μήνες μετά την υπόδειξη κάποιου ειδικού, που στο 47,5% ήταν από κάποιον λογοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή. Το 52,5% είχε δυσκολίες στην εύρεση ραντεβού ή την πρόσβαση ενώ κανένας συμμετέχων δεν έλαβε οικονομική βοήθεια από το κράτος για κανένα στάδιο, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιου είδους βοήθεια θεσμοθετημένη. Από τους διαγνωσμένους με ΔΑΕ, το 70,4% ένιωσε την αποδοχή μετά τη διάγνωση αν και μόνο το 44,4% έλαβε υποστήριξη. Το 74,1% αυτών προχώρησαν στην ακουστική εκπαίδευση με το 63% εξ' αυτών να επιλέγει κάποιον λογοθεραπευτή. Στο 33,3% εξ' αυτών δεν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις στο περιβάλλον. Τέλος, για όσους διαγνώστηκαν με ΔΑΕ το 51,9% είχε αρνητικές εμπειρίες που να σχετίζονται με τη διαγνωστική διαδικασία και την αποκατάσταση της ΔΑΕ ενώ για όσους είχαν φυσιολογική ακουστική επεξεργασία το ποσοστό ήταν μόλις 46,2%. Οι θετικές εμπειρίες αντιστοιχούσαν σε 59,3% και 61,5% αντίστοιχα.

Συμπεράσματα: Η μελέτη καταλήγει ότι, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις επιτυχούς διαχείρισης της ΔΑΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στην ενημέρωση και την υποστήριξη. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση επαγγελματιών, παροχή

χρηματοδότησης για θεραπείες και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού. Η εργασία τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης προσέγγισης στη φροντίδα ατόμων με ΔΑΕ και προτείνει κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.

Abstract

Background: Auditory Processing Disorder (APD) affects individuals' ability to understand and process auditory information despite having normal hearing acuity. The diagnostic assessment of APD relies on a series of specialized auditory and cognitive tests, as well as clinical evaluations, since it cannot be detected through standard audiometric examinations. APD can cause significant difficulties in daily life, particularly in noisy environments or when multiple speech sources are present. Although awareness of the disorder is increasing, the experiences of individuals with APD, especially during the assessment and rehabilitation process, have not been sufficiently explored.

Objective: The primary aim of this study is to examine the experiences of individuals with APD in areas such as healthcare, education, and the workplace. Specifically, the study seeks to highlight the challenges these individuals face during diagnostic assessment and rehabilitation, as well as explore both their positive and negative experiences.

Methodology: The study employed thematic analysis to process data collected through questionnaires. The questionnaires targeted individuals who had completed the diagnostic assessment for APD and were either diagnosed with APD or had normal auditory processing. They focused on their experiences with healthcare professionals, educators, and other professionals, as well as the difficulties they encountered in daily situations.

Results: The findings of the study highlight that 82.5% of the total 40 participants had an additional diagnosis before being evaluated for APD, while 67.5% were diagnosed with APD. A total of 90% of individuals consulted a

specialist within the first six months after being referred by a professional, with 47.5% of these referrals coming from a speech therapist or occupational therapist. Additionally, 52.5% faced difficulties in securing an appointment or accessing services, while none of the participants received financial assistance from the state at any stage, as no such aid is institutionally provided. Among those diagnosed with APD, 70.4% felt accepted after their diagnosis, though only 44.4% received support. Furthermore, 74.1% of those diagnosed proceeded with auditory training, with 63% choosing a speech therapist. However, in 33.3% of cases, the necessary environmental modifications were not implemented. Lastly, among those diagnosed with APD, 51.9% reported negative experiences related to the diagnostic process and rehabilitation, whereas for those with typical auditory processing, the percentage was only 46.2%. Positive experiences accounted for 59.3% and 61.5%, respectively.

Conclusions: The study concludes that while there are cases of successful APD management, significant gaps remain in awareness and support. The recommendations include the need for further professional education, financial assistance for therapies, and increased public awareness. The research highlights the importance of a comprehensive approach to the care of individuals with APD and suggests directions for future studies.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) αποτελεί μια ξεχωριστή νευρολογική κλινική κατάσταση που επηρεάζει την ακουστική ικανότητα και την ψυχική υγεία, καθώς η επεξεργασία των ακουστικών πληροφοριών από τον εγκέφαλο είναι ελλιπής, οδηγώντας σε δυσκολίες κατανόησης και επικοινωνίας (Κουκουβέτσου, 2020; ASHA, 2022; Samara et al., 2023). Πρακτικά, αποτελεί ένα σύνθετο ακουστικό έλλειμμα που επηρεάζει την ικανότητα του εγκεφάλου να ερμηνεύει αποτελεσματικά τους ήχους, οδηγώντας σε δυσκολίες στην κατανόηση της ομιλίας, την παρακολούθηση των οδηγιών και τη συμμετοχή σε συνομιλίες (ASHA, 2005; Ηλιάδου, 2015; Bellis, 2015; Mountjoy, 2021). Παρά τον επιπολασμό της, που κυμαίνεται από 3-20% ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και τη μέθοδο αξιολόγησης (Nagao et al., 2016; Geffner & Ross-Swain, 2019), η ΔΑΕ παραμένει ανεπαρκώς αναγνωρίσιμη και διαγνωσμένη (Chermak & Musiek, 1997; Keith, 1999; Iliadou & Bamiou, 2012). Επομένως, «τι κάνουμε με αυτό που ακούμε;» (Lasky & Katz, 1983).

1.1 Ορισμός Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας

Σύμφωνα με το European Consensus (Iliadou et al., 2017) και πρόσφατα δεδομένα (Iliadou et al., 2024), η ΔΑΕ αναγνωρίζεται ως μια ξεχωριστή νευρολογική κατάσταση που επηρεάζει πρωτίστως το Κεντρικό Ακουστικό Νευρικό Σύστημα (ΚΑΝΣ). Ορίζεται ως ένα «*Συγκεκριμένο έλλειμμα στην επεξεργασία ακουστικών πληροφοριών κατά μήκος του κεντρικού ακουστικού νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της νευρικής συνδεσιμότητας από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω*»

(Iliadou et al., 2017). Ο επιπολασμός της διαταραχής, σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, κυμαίνεται από 1,94 ανά 1.000 παιδιά (Nagao et al., 2016) έως και 20% σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (Geffner & Ross-Swain, 2019) με τη μεγαλύτερη συχνότητα να εμφανίζεται σε άτομα σχολικής ηλικίας και άνω των 60 ετών (American Academy of Audiology, 2010; Geffner & Ross-Swain, 2019; Messersmith et al., 2019). Συχνά συνυπάρχει με άλλες διαταραχές, όπως ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD), και διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (Ricci & Hynd, 1996; Dawes & Bishop, 2009; Bellis, 2015; Iliadou et al., 2017). Η ύπαρξη συννοσηρότητας απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση για τη διάγνωση και την αποκατάσταση (Miller, 2011; Iliadou et al., 2017; Iliadou et al., 2024).

Τα άτομα με ΔΑΕ παρουσιάζουν φυσιολογική ανατομία του εξωτερικού, του μέσου και του εσωτερικού αυτιού με πλήρη λειτουργία αυτών, έχοντας φυσιολογική ευαισθησία ακοής (Iliadou et al., 2009; Musiek & Baran, 2020; Central Auditory Processing Disorder, 2022). Ωστόσο, επειδή παρουσιάζονται ελλείμματα στη νευρωνική επεξεργασία των ακουστικών ερεθισμάτων, που δεν προέρχονται από ανώτερη γνωστική ή γλωσσική διαταραχή (ASHA 2005; Moore et al., 2013; Aristidou & Hohman, 2022), τα άτομα αυτά αγωνίζονται να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν με ακρίβεια τα ακουστικά ερεθίσματα (Hall 2014; Moore et al., 2017; Vermiglio et al. 2019, Central Auditory Processing Disorder, 2022). Σημαντικές επιπτώσεις της ΔΑΕ στην ποιότητα ζωής των ασθενών αποτελούν, οι δυσκολίες στην αντίληψη της ομιλίας (Phillips, 2002; Sharma et al., 2009; Lagacé et al., 2010; Musiek & Chermak, 2014; Flanagan et al., 2018), την ακουστική διάκριση (Musiek & Chermak, 2014; Ludwig et al., 2019; RW, 2023), τον εντοπισμό ήχου (Moore et al., 2010; Lotfi et al., 2020),

καθώς και χαμηλές επιδόσεις στην προσοχή και τη μνήμη (Sharma et al., 2014; Tomlin et al., 2015), που τονίζουν την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση (Dawes & Bishop, 2009; Iliadou et al., 2009; Sharma et al., 2009; Lin et al., 2011; Moore & Hunter, 2013).

Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την προωρότητα, λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, επιπλοκές κατά την κύηση, μεγαλύτερη ηλικία της μητέρας καθώς και οποιαδήποτε νευρολογική διαταραχή τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες (Katz & Tillery, 2005; Bellis 2015; Moore et al., 2017; Geffner & Ross-Swain, 2019; Central Auditory Processing Disorder, 2022).

1.2 Συμπτωματολογία της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας

Τα άτομα με ΔΑΕ ενδέχεται να εμφανίζουν δυσκολίες στην αναγνώριση, διάκριση και κατανόηση ήχων, ειδικά όταν το περιβάλλον είναι θορυβώδες ή όταν η πληροφορία είναι περίπλοκη (Moore et al., 2008; Sharma et al., 2009; Cacace & McFarland, 2009; Musiek & Chermak, 2014; Central Auditory Processing Disorder, 2022). Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα του ατόμου σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση (Dawes et al., 2010; Gertsovski & Ahissar, 2022; Banumathi & Jain, 2023), η εργασία (Purdy & Keith, 2014; Alanazi, 2023), η ψυχική υγεία (Vander Werff & Burns, 2011; Nkyekyer et al., 2019) και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Gyldenkaerne et al., 2014). Τα συμπτώματα της ΔΑΕ ποικίλλουν από άτομο σε άτομο, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν τα εξής:

1. *Δυσκολία στην κατανόηση ομιλίας σε θόρυβο*: Αυτό οφείλεται στην αδυναμία του εγκεφάλου να διακρίνει τη σημασία του ακουστικού σήματος από τον περιβάλλοντα θόρυβο (Rosenberg Center, 2017;

Geffner & Ross-Swain, 2019; Samara et al., 2023; Iliadou et al., 2024).

Τα άτομα με ΔΑΕ δυσκολεύονται να διαχειριστούν την ακουστική ένταση και να διαχωρίσουν την ομιλία ερέθισμα από άλλους ήχους.

2. *Δυσκολία στη διάκριση ήχων ή φωνημάτων:* Οι πάσχοντες από ΔΑΕ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διάκριση μικρών διαφορών μεταξύ ήχων ή φωνημάτων, γεγονός που επηρεάζει την κατανόηση των λέξεων (Rosenberg Center, 2017). Ειδικότερα, μπορεί να υπάρχει δυσκολία στην διάκριση παρόμοιων λέξεων ή ήχων που διαφέρουν μόνο ελάχιστα μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα «μπανάνα» και «μανάνα» (Iliadou et al., 2017).
3. *Δυσκολία στη διάκριση της κατεύθυνσης των ήχων:* Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ΔΑΕ είναι η δυσκολία εντοπισμού της κατεύθυνσης από την οποία προέρχεται ο ήχος (Rosenberg Center, 2017). Η διάκριση της κατεύθυνσης του ήχου είναι σημαντική για την κατανόηση του περιβάλλοντος και την αναγνώριση ερεθισμάτων που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές πηγές (DeBonis, 2015).
4. *Προβλήματα με τη μνήμη εργασίας και την ακουστική επεξεργασία:* Οι δυσκολίες στη μνήμη εργασίας, ειδικά όσον αφορά την αποθήκευση και την αναπαραγωγή ακουστικών πληροφοριών, είναι συχνές σε άτομα με ΔΑΕ (Rosenberg Center, 2017). Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα κατανόησης πολύπλοκων προφορικών οδηγιών ή πληροφοριών, καθώς η ακουστική πληροφορία δε διατηρείται αποτελεσματικά στο βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο σύστημα μνήμης (Nagao et al., 2016).

5. *Δυσκολία στη διαχείριση ακουστικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο*: Τα άτομα με ΔΑΕ ενδέχεται να έχουν αυξημένες δυσκολίες στη διαχείριση ακουστικών ερεθισμάτων και πληροφοριών έχουν ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται η απόδοσή τους σε καταστάσεις που απαιτούν ταχεία αντίδραση, όπως στη διαχείριση πολύπλοκων ήχων που απαιτούν επεξεργασία και άμεση αντίδραση (Dawes & Bishop, 2009; Rosenberg Center, 2017).
6. *Ευαισθησία στους ήχους*: Ορισμένα άτομα με ΔΑΕ μπορεί να παρουσιάζουν υπερευαισθησία σε ήχους, με αποτέλεσμα να βιώνουν δυσφορία ή άγχος σε περιβάλλοντα με δυνατούς ήχους ή έντονο θόρυβο (Rosenberg Center, 2017; Geffner & Ross-Swain, 2019).

Η συννοσηρότητα της ΔΑΕ με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, όπως η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ADHD) και οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, συχνά καθιστούν τη διαγνωστική εξέταση για την ακουστική επεξεργασία με βάση τα κριτήρια του European Consensus (Iliadou et al.2017) πιο περίπλοκη. Στην περίπτωση αυτών των συννοσηροτήτων, η ύπαρξη κοινών συμπτωμάτων μπορεί να επηρεάσει την υποψία ύπαρξης της ΔΑΕ και να καθυστερήσει την παραπομπή του ατόμου για ειδικό έλεγχο και διάγνωση. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα των Iliadou et al. (2017), η ΔΑΕ μπορεί να παραμείνει αδιάγνωστη ή να συγχέεται με άλλες διαταραχές λόγω των κοινών συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Τόσο η απώλεια ακοής όσο και η Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας έχουν συσχετιστεί σημαντικά με χαμηλότερες βαθμολογίες στις μετρήσεις για

την ψυχική υγεία, τη μνήμη και τις εκτελεστικές λειτουργίες (Lin et al., 2011). Ως αποτέλεσμα, η τελική εικόνα των ασθενών με ΔΑΕ, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δείχνει αρκετά επηρεασμένη σε όλους τους τομείς ζωής ενός ανθρώπου (Heine & Slone, 2008; Kreisman et al., 2012; Del Zoppo et al., 2014; Hrastinski et al., 2023).

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Μειμάρογλου το 2023 σχετικά με τις σύγχρονες ιατροπαιδαγωγικές γνώσεις στην Ελλάδα ως προς τη Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας, αποδείχτηκε πως οι ειδικότητες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη ΔΑΕ φαίνεται να κατέχουν γνώσεις σε επίπεδα που επιδέχονται βελτίωσης, με αστοχίες στην αυτό-αξιολόγησή τους (Μειμάρογλου, 2023; Bernard et al., 2024). Το γεγονός αυτό μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιδράσεις στον τρόπο που τα άτομα με ΔΑΕ αντιμετωπίζονται από την στιγμή της παραπομπής και διάγνωσης, μέχρι την παρέμβαση (Μειμάρογλου, 2023).

Αντίθετα, σε έρευνα που διενεργήθηκε στη Βρετανία, 63% των υγειονομικών θεωρούσαν ότι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τη ΔΑΕ, ενώ το 4% αισθανόταν πολύ ενημερωμένο (Bernard et al., 2024).

Στην Ελλάδα, η υπερ-διάγνωση των γνωστικών ελλειμμάτων σε ψυχιατρικούς ασθενείς μπορεί να είναι αποτέλεσμα της απουσίας ελέγχου της ευαισθησίας της ακοής και της ακουστικής επεξεργασίας (Iliadou et al., 2018).

1.3 Διάγνωση της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας

Για τον έλεγχο της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας, οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν συχνότερα τεστ ακουστικής επεξεργασίας σε ενήλικες και λήψη ιστορικού σε παιδιά, ενώ οι συνήθεις ακουολογικές διαδικασίες είναι η κύρια διαγνωστική εξέταση της ΔΑΕ και στις δύο ηλικιακές

ομάδες (Bernard et al., 2024). Αυτό προκύπτει καθώς εξακολουθούν να μην υπάρχουν καθολικώς αποδεκτά κριτήρια για τη διάγνωση (Wilson και Arnott, 2013; Vermiglio, 2016; Moore, 2018; Iliadou et al., 2018; BSA, 2018; Dillon & Cameron, 2021).

Σταθμισμένα ερωτηματολόγια, όπως το Children's Auditory Processing Performance Scale, το Fisher's Auditory Problems Checklist) και το Auditory Processing Domains Questionnaire, είναι διαθέσιμα για παιδιά, ενώ ερωτηματολόγια για ενήλικες περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τις ακουστικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη ΔΑΕ (Samara et al., 2023). Επίσης, η διαγνωστική εξέταση για την ακουστική επεξεργασία σύμφωνα με το European Consensus (Iliadou et al. 2017), περιλαμβάνει μια ποικιλία τεχνικών, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές πλευρές της ακουστικής επεξεργασίας, όπως ο έλεγχος της φυσιολογικής ακοής, η αντίληψη της ομιλίας σε θόρυβο σε δοκιμασίες που αξιολογούν την ικανότητα διάκρισης, αναγνώρισης ή κατανόησης ήχων, η χρήση εξειδικευμένων δοκιμασιών όπως το GIN Test, το Dichotic Digits Test και το Frequency Pattern Test (Iliadou et al. 2017). Αυτές οι δοκιμασίες βοηθούν ώστε να εντοπιστούν οι τομείς της ακουστικής επεξεργασίας που επηρεάζονται από τη ΔΑΕ, και συχνά συνδυάζονται με γλωσσικές και γνωστικές αξιολογήσεις για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του ασθενούς (DeBonis, 2015). Η συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων αναγνωρίζεται ως απαραίτητη για τη διαχείριση της ΔΑΕ (Iliadou et al., 2018; Iliadou et al., 2024; Bernard et al., 2024).

1.4 Αποκατάσταση της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας

Η διαχείριση και αποκατάσταση των διαταραχών ακουστικής επεξεργασίας (ΔΑΕ) αποτελεί ένα σύνθετο και αναπτυσσόμενο πεδίο, που απαιτεί συνεχιζόμενη έρευνα. Παρόλο που η τροποποίηση του ακουστικού περιβάλλοντος συνιστάται ευρέως ως στρατηγική διαχείρισης της ΔΑΕ, το 50% των συμμετεχόντων σε έρευνα που διενεργήθηκε στην Βρετανία από τους Bernard et al. (2024) ανέφερε ότι η διάγνωση της ΔΑΕ δεν οδήγησε σε καμία τροποποίηση του ακουστικού περιβάλλοντος των ασθενών.

Οι στρατηγικές και οι προσεγγίσεις παρέμβασης, όπως η εκπαίδευση ακουστικού κλεισίματος, βασίζονται στη χρήση γνώσης και εμπειριών για την ερμηνεία ακουστικών ερεθισμάτων που μπορεί να έχουν χαθεί λόγω εσωτερικής υποβάθμισης (Seewald & Bamford, 2008). Όσο πιο αναπτυγμένο είναι το λεξιλόγιο του ασθενούς, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η θεραπεία (Mokhemar, 1999; Heine & Panayiotou, 2004).

Η έγκαιρη διαγνωστική εξέταση για τη ΔΑΕ επιτρέπει την εκμετάλλευση της πλαστικότητας του εγκεφάλου για αναδιοργάνωση του φλοιού και του εγκεφαλικού στελέχους, με τις εντατικές παρεμβάσεις να οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα (Moore, 2011). Η διαγνωστική εξέταση και η θεραπεία ανατίθενται στους ΩΡΛ, ενώ οι λογοθεραπευτές, οι εκπαιδευτικοί και οι ακοολόγοι παρέχουν την αποκατάσταση (Emanuel et al., 2011; Bernard et al., 2024). Στο σχολικό περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά μπορούν να εκπαιδευτούν για να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για άτομα με ΔΑΕ (Seewald & Bamford, 2008).

Ωστόσο, είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε τις προκλήσεις στην πρόσβαση, τη διάγνωση / αναγνώριση και την αποκατάσταση της ΔΑΕ, και να

ενισχύσουμε την υποστήριξη για τα άτομα και τις οικογένειές τους. Η ενημέρωση του σχεδιασμού για εκπαίδευση, έρευνα και κλινικές υπηρεσίες είναι σημαντική για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης φροντίδας (Hollis et al., 2023; Clark et al., 2023; Bernard et al., 2024).

1.5 Βιβλιογραφική ανασκόπηση των εμπειριών ασθενών με ΔΑΕ

Ο τομέας της ακουστικής επεξεργασίας έχει αναδειχθεί πρόσφατα με πιο συστηματικό τρόπο στην έρευνα, αν και παραμένει σημαντικό το κενό στην κατανόηση των υποκειμενικών εμπειριών των ατόμων με ΔΑΕ. Οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται σε αντικειμενικές μετρήσεις και διαγνωστικά κριτήρια, παραβλέποντας τη βιωμένη πραγματικότητα και τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις για τους ασθενείς (Cameron & Dillon, 2008).

Το άρθρο των Samara et al. (2023), που αποτελεί μια συστηματική ανασκόπηση και μετά-ανάλυση ορισμένων ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και τον έλεγχο της ακουστικής επεξεργασίας (ΔΑΕ), εξετάζει την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων στην ανίχνευση των προβλημάτων ακουστικής επεξεργασίας, ειδικά σε περιβάλλοντα με θόρυβο ή περίπλοκες ακουστικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες μεθόδους εκτίμησης αυτών των διαταραχών. Η ανάγκη, λοιπόν, για περισσότερη έρευνα σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης και αποκατάστασης των ασθενών καθίσταται αναγκαία. Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνουν και οι Iliadou et al., (2024) εκφράζοντας την ανάγκη για αναθεώρηση των τρεχουσών μεθόδων αξιολόγησης της ακοής, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και διάγνωση των ακουστικών διαταραχών.

Η έρευνα των Agrawal et al. (2021), που περιλάμβανε 156 συμμετέχοντες, ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΕ, όπως τις δυσκολίες στη διάγνωση, τη χρηματοδότηση εξοπλισμού και την αναγνώριση της διαταραχής. Παρά τις αρνητικές εμπειρίες, αναφέρθηκαν και θετικά στοιχεία, όπως η υποστήριξη στο σχολείο και η αποκατάσταση κατά την λήψη διάγνωσης. Οι συστάσεις για βελτίωση περιλάμβαναν εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και εκπαιδευτικών και ευαισθητοποίηση του κοινού (Agrawal et al., 2021).

Η μελέτη αναγνωρίζει τους περιορισμούς της, όπως πιθανές προκαταλήψεις στις απαντήσεις των συμμετεχόντων και τη χρήση ενός δείγματος ευκολίας. Ωστόσο, υπογραμμίζει τη σημασία της ικανοποίησης των αναγκών των ατόμων με ΔΑΕ και των οικογενειών τους, της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και της αντιμετώπισης των ερευνητικών προτεραιοτήτων για την καλύτερη κατανόηση και υποστήριξη όσων διαγιγνώσκονται με ΔΑΕ (Agrawal et al., 2021).

Η μελέτη των Bamiou et al. (2006) σε 85 άτομα (ασθενείς και μη) ηλικίας 18-60 ετών, επισημαίνει τη χρησιμότητα των ερωτηματολογίων ακοής ως πολύτιμων εργαλείων προσυμπτωματικού ελέγχου για τον εντοπισμό ατόμων με πιθανές διαταραχές ακουστικής επεξεργασίας (Bamiou et al., 2006; Bernard et al., 2024). Με την ενσωμάτωση υποκειμενικών αυτό-αναφορών σε αντικειμενικές αξιολογήσεις, οι ακολόγοι μπορούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση των ικανοτήτων ακουστικής επεξεργασίας ενός ατόμου και να προσαρμόσουν ανάλογα τις παρεμβάσεις. (Bernard et al., 2024) Η αναγνώριση των υποκειμενικών εμπειριών, όπως για

παράδειγμα η δυσκολία στην κατανόηση ομιλίας σε θορυβώδη περιβάλλοντα, συσχετίζεται με χαμηλότερες επιδόσεις σε αντικειμενικές δοκιμασίες (Iliadou et al., 2009; Bernard et al., 2024).

Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί πως αυτά τα κείμενα, που υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση λήψη της πληροφορίας σχετικά με τη ΔΑΕ μέσω των ίδιων των ασθενών με ΔΑΕ και των οικείων τους, είναι τα μοναδικά βιβλιογραφικά αρχεία που διαθέτουμε για την υποκειμενική καταγραφή της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας. Θα ήταν βοηθητικό, τόσο για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με ΔΑΕ, όσο και για την αυξημένη ευαισθητοποίηση και αναγνώρισή της σε διάφορους τομείς, να υπάρξουν έρευνες ανά τον κόσμο με την προσωπική καταγραφή του κάθε ασθενούς (Bernard et al., 2024).

Το εισαγωγικό τμήμα αυτής της διατριβής εστιάζει στη διερεύνηση των εμπειριών των ατόμων με ΔΑΕ κατά τη διαγνωστική εξέταση για την ακουστική επεξεργασία με βάση τα κριτήρια του European Consensus (Iliadou et al. 2017), αλλά και κατά την αποκατάσταση, εξετάζοντας τόσο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσο και τις ευκαιρίες για βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας. Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει στη χαρτογράφηση των υποκειμενικών εμπειριών των ασθενών και των οικογενειών τους στον Ελλαδικό χώρο, αναδεικνύοντας τα κενά στις υπάρχουσες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, εστιάζει στη συμβολή αυτών των εμπειριών στην ανάπτυξη εξατομικευμένων παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων (Iliadou et al., 2024). Η έρευνα φιλοδοξεί να

αναδείξει την υποκειμενική διάσταση της διαταραχής και να προτείνει βελτιώσεις για τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη των ασθενών.

2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.1 Συμμετέχοντες

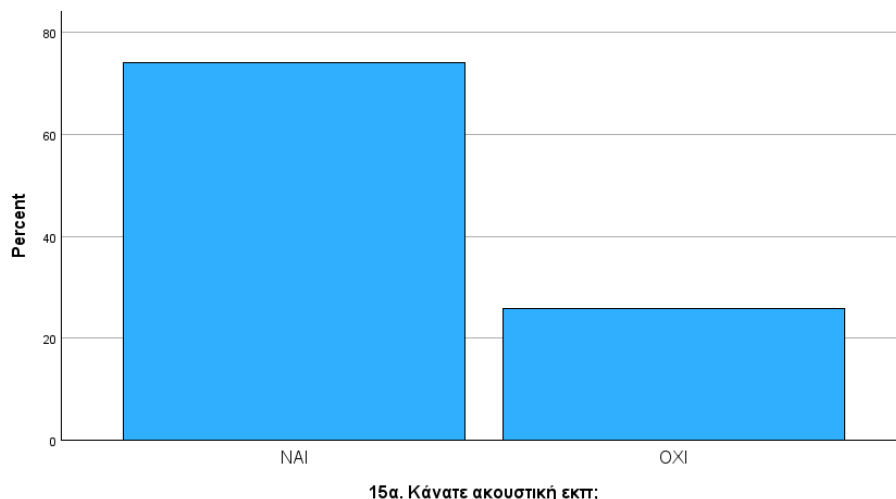
Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν συνολικά 40 άτομα. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από το αρχείο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», για το διάστημα από το 2019 έως το 2024, με ένα πολύ μικρό ποσοστό να έχει αρνηθεί την συμμετοχή του στην έρευνα (3%). Το δείγμα αποτελείτο από 6 ενήλικες με μέσο όρο ηλικίας 37,83 (Std. Deviation= 12,024) και από 34 παιδιά με μέσο όρο ηλικίας 8,24 (Std. Deviation= 2,175).

Το 82,5% των συμμετεχόντων είχε συνοδές δυσκολίες ή διαγνώσεις. Διάγνωση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είχε λάβει το 17,5%, Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος το 15%, ενώ το 10% είχε απώλεια ακοής ή φωνολογική διαταραχή. Μικρότερα ποσοστά είχε η συννοσηρότητα με δυσλεξία, ΔΕΠ-Υ, επιληψία και ψυχιατρικές διαταραχές.

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	Κανένα	7	17,5	17,5
	ΔΑΦ	6	15,0	15,0
	ΔΕΠ-Υ	2	5,0	5,0
	Δυσλεξία	1	2,5	2,5
	Απώλεια ακοής	4	10,0	10,0
	Μαθησιακές δυσκολίες	7	17,5	17,5
	Φωνολογική διαταραχή	4	10,0	10,0
	Διπολική διαταραχή	1	2,5	2,5
	Επιληψία	1	2,5	2,5
	Διαταραχή άρθρωσης	1	2,5	2,5
	Ρευματοειδής αρθρίτιδα	1	2,5	2,5
	Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού συστήματος	1	2,5	2,5
	Άλλο,...	4	10,0	10,0

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 20% είχαν αξιολογηθεί για ΔΑΕ οι ίδιοι, ενώ το 80% ολοκλήρωσε την έρευνα για λογαριασμό του γιου ή της κόρης τους. Ένας μόνο συμμετέχων ανέφερε ότι αξιολογήθηκαν περισσότερα από ένα άτομα για ΔΑΕ στην οικογένειά του (και τα δυο παιδιά του). Οι ενήλικες απαντούσαν οι ίδιοι στην συνέντευξη / ερωτηματολόγιο ενώ για τους ανήλικους απαντούσαν οι γονείς / κηδεμόνες τους.

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 67,5% πληρούσε τα κριτήρια με βάση το European Consensus (Iliadou et al. 2017) για τη λήψη διάγνωσης ΔΑΕ, ενώ το 32,5% είχε φυσιολογική ακουστική επεξεργασία. Από το ποσοστό που διαγνώστηκε με ΔΑΕ κατά τη διαγνωστική εξέταση, μόνο το 74,1% προχώρησε στο στάδιο της αποκατάστασης, δίνοντάς μας πληροφορίες και για αυτόν τον τομέα.



Οι συμμετέχοντες διέμεναν σε διάφορα μέρη ανά την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Καστοριά, Αθήνα, Λάρισα, Βόλο κ.ά.) χωρίς να αξιολογείται το πόσο κοντά ή μακριά βρίσκονται από το κέντρο μεγάλων πόλεων ενώ βασικό κριτήριο επιλογής για όλους τους συμμετέχοντες ήταν να έχουν ολοκληρώσει τη διαγνωστική εξέταση για την ακουστική επεξεργασία. Η συμμετοχή τους στην έρευνα ήταν ανώνυμη και εθελοντική (Groves et al., 1997).

2.2 Υλικό

Για τη διεκπεραίωση της έρευνας, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο στο αντίστοιχο Βρετανικό (Agrawal et al., 2021) και τροποποιημένο ώστε να ταιριάζει στην ελληνική κουλτούρα, απαρτιζόμενο από 23 ερωτήσεις. Οι τροποποιήσεις αφορούσαν την ύπαρξη ή μη κρατικής χρηματοδότησης, την αναγνώριση της ΔΑΕ σε κοινωνικά περιβάλλοντα και τις ευκολίες και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στα άτομα με ΔΑΕ στον τομέα της ακουστικής εκπαίδευσης, καθώς δεν υπάρχει πληθώρα εξειδικευμένων στον Ελλαδικό χώρο. Από τις 23 ερωτήσεις, οι 11 ήταν κλειστού, οι 7 ανοιχτού τύπου σχετικά με την εμπειρία ασθενών με ΔΑΕ και 5 ήταν ημι-δομημένες. Ο

σκοπός του ερωτηματολογίου ήταν η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διάγνωση της ΔΑΕ, την πρόσβαση σε υπηρεσίες, την υποστήριξη των ατόμων μετά τη λήψη διάγνωσης ΔΑΕ, τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες ασθενών που σχετίζονται με την διαγνωστική εξέταση ή / και την αποκατάσταση για ΔΑΕ, καθώς και προτάσεων για βελτιώσεις (Bamiou et al., 2015; Agrawal et al., 2021).

Το ερωτηματολόγιο, όπως και η ανάλυση δεδομένων, βασίστηκε στην έρευνα των Agrawal et al. (2021), που αφορούσε αντίστοιχα τη Βρετανική κοινότητα. Χρησιμοποιήθηκαν αρκετές ερωτήσεις από την παραπάνω έρευνα (τροποποιημένες για την ελληνική πραγματικότητα) ενώ εντάχθηκαν και ερωτήσεις, ύστερα από απορίες που προέκυψαν, μετά την ανάλυση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας σχετικά με την ΔΑΕ. (Back et al., 2021; Ahmmed et al., 2022; Ansar Ahmmed & Vijayakumar, 2024; Drosos et al., 2024).

Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονταν ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα, ερωτήσεις σχετικά με δυσκολίες στη λήψη υπηρεσιών υποστήριξης στον ελλαδικό χώρο αλλά και η καταγραφή όλων των θετικών ή αρνητικών εμπειριών των ασθενών, καθώς και οι απόψεις τους για βελτιώσεις σχετικά με τη διαταραχή. (Βλ. *πίνακα 1*)

2.3 Διαδικασία

Η παρούσα έρευνα αποτελεί προϊόν μικτής μεθοδολογικής έρευνας καθώς η συλλογή δεδομένων και μέρος των αποτελεσμάτων πάρθηκαν και αναλύθηκαν δια μέσου της ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων (thematic analysis), ενώ ένα άλλο μέρος των αποτελεσμάτων αναλύθηκε, συγκρίθηκε και περιγράφηκε δια μέσου της ποσοτικής μεθόδου (χρήση IBM SPSS). Ο

στόχος της χρήσης και των δύο μεθόδων είναι να μας προσφέρει μεγαλύτερη διορατικότητα στην τελική ανάλυση των στοιχείων που έχουν ληφθεί (Creswell & Creswell, 2023).

Για να ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης του ερωτηματολογίου, ο κάθε συμμετέχων όφειλε να έχει υπογράψει το έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 38/2023, και να το έχει αποστείλει με e-mail στους συγγραφείς της έρευνας. Για τα ανήλικα τέκνα υπέγραφαν το έντυπο οι γονείς / κηδεμόνες τους, οι οποίοι απαντούσαν και στο ερωτηματολόγιο. Τέλος, οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν για το δικαίωμά τους να αποχωρήσουν από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή, αν το επιθυμούν, αποστέλλοντας υπογεγραμμένο το έντυπο ανάκλησης συγκατάθεσης που τους είχε δοθεί εξ αρχής μαζί με το έντυπο συγκατάθεσης. Η χορήγηση του ερωτηματολογίου ξεκινούσε αμέσως μετά, σε καθορισμένο τηλεφωνικό ραντεβού με τον συμμετέχοντα.

Η χορήγηση πραγματοποιήθηκε εξ' αποστάσεως μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Η διάρκεια της διαδικασίας κυμαινόταν από δεκαπέντε (15) λεπτά μέχρι μισή ώρα (30 λεπτά), ανάλογα με τις πληροφορίες που ο κάθε συμμετέχων ήθελε να μοιραστεί.

Σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης δίνονταν στα άτομα μόνο διευκρινιστικά παραδείγματα προς επιβεβαίωση ότι η απάντησή τους γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δόθηκαν (κυρίως στην ερώτηση 22, « *Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι πιο σημαντικοί τομείς δημόσιας πολιτικής που σχετίζονται*

με την ΔΑΕ;») ενώ τα παραδείγματα ήταν για όλους τους συμμετέχοντες τα ίδια.

2.4 Στατιστική ανάλυση

Οι απαντήσεις κλειστού τύπου αναλύθηκαν ποσοτικά με την χρήση του προγράμματος IBM SPSS και οι απαντήσεις ανοιχτού τύπου αναλύθηκαν ποιοτικά μέσω της μεθόδου Thematic Analysis. Οι 5 ημι-δομημένες ερωτήσεις αναλύθηκαν και με τους δύο τρόπους.

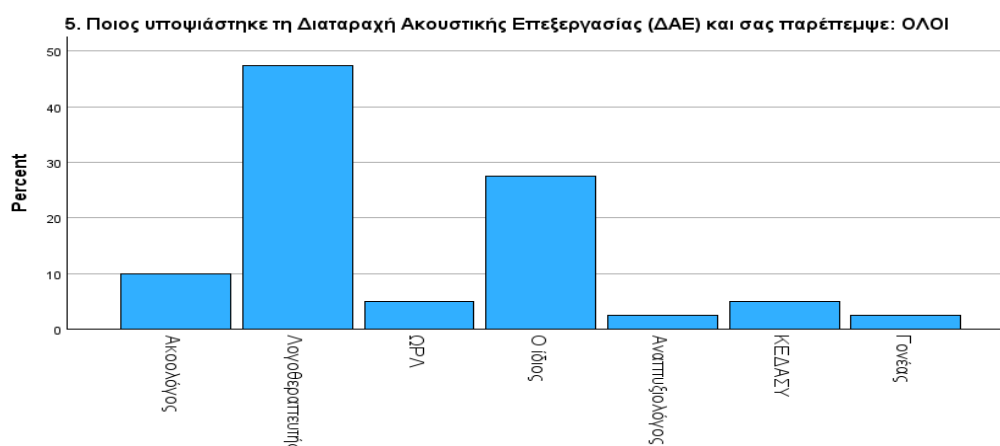
Τέσσερις a priori τομείς δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις ερωτήσεις της έρευνας: Ενημέρωση και εκπαίδευση, υποστήριξη και χρηματοδότηση, ευαισθητοποίηση και στήριξη στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον, διαγνωστική διαδικασία και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Στη συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώθηκε στον εντοπισμό υποτομέων καθενός από αυτούς τους τομείς ακολουθώντας το περιεχόμενο των ερωτήσεων με μεθόδους ανάλυσης και βήματα που εισήγαγαν οι Braun & Clarke (2019). Οι τομείς και οι υποτομείς δημιουργήθηκαν αρχικά από τους συγγραφείς της παρούσας έρευνας, εξετάστηκαν εξονυχιστικά και τελικά αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel για Office 365.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1 Ανάπτυξη των Θεμάτων με Παραδείγματα από τα Δεδομένα

Η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων είναι το πρώτο βήμα ώστε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία της επανεξέτασης αυτών και έπειτα να δούμε αναλυτικά τις ερωτήσεις και τι αποτελέσματα μας πρόσφεραν.

Γνωρίζοντας από τα δημογραφικά δεδομένα τις ηλικίες κατά τις οποίες τα άτομα υπεβλήθησαν στην διαγνωστική εξέταση για ΔΑΕ βλέπουμε πως το 85% των συμμετεχόντων είναι παιδιά. Επομένως, αναμένουμε δυσκολία στην παρατήρηση της ύπαρξης πιθανών συμπτωμάτων για ΔΑΕ από τα ίδια τα άτομα. Για τον λόγο αυτό, αναζητήσαμε τα άτομα που υποψιάστηκαν την ύπαρξη της διαταραχής και παρέπεμψαν σε εξειδικευμένους ΩΡΛ για διαγνωστική εξέταση ΔΑΕ. Φάνηκε, λοιπόν, πως στο 47,5% παρατήρησε τις δυσκολίες ο λογοθεραπευτής, 10% εξειδικευμένος ΩΡΛ / ακοολόγος, ενώ το 27,5% (συμπεριλαμβανομένων και των ενηλίκων) παρατήρησαν οι ίδιοι δυσκολίες που πιθανόν να σχετίζονταν με την ΔΑΕ.



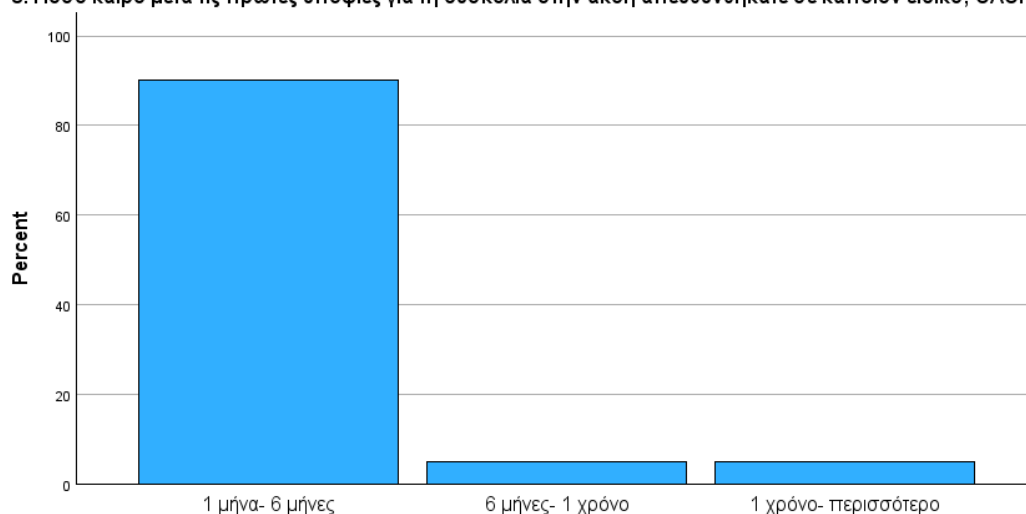
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ως προς τα χαρακτηριστικά των δυσκολιών που παρατήρησαν είτε οι ίδιοι στον εαυτό τους είτε οι γονείς / κηδεμόνες στα παιδιά τους. Από τις απαντήσεις βλέπουμε διάφορες περιγραφές των παρατηρούμενων συμπτωμάτων, όπως:

- *Συνεχείς ερωτήσεις τύπου "Τι;".*

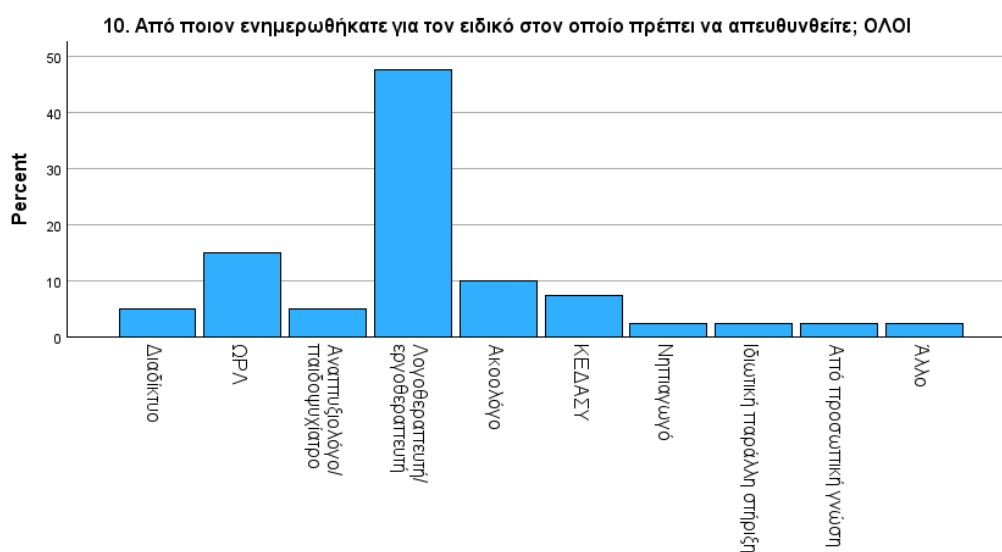
- *Δυσκολία κατανόησης λόγου σε θορυβώδη περιβάλλοντα:* Υπάρχουν περιπτώσεις που περιγράφουν δυσκολία να κατανοήσει κανείς ομιλία όταν υπάρχει παρακώλυση ή θόρυβος στο περιβάλλον.
- *Χρησιμοποίηση λέξεων που δεν έχουν νόημα ή αυξομειώσεις στην ένταση της φωνής τους.*
- *Εξάρτηση από εξωτερικά βοηθήματα (ακουστικά βαρηκοΐας) ή συμπεριφορές (όπως να φωνάζει ή να ζητά επανάληψη της πληροφορίας).*
- *Δυσκολία συγκέντρωσης και διαταραχές προσοχής.*

Σημαντικές ήταν οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο αναμονής που υπήρξε από τις πρώτες υποψίες για δυσκολίες ακουστικής επεξεργασίας στο άτομο μέχρι την κινητοποίηση για την υποβολή του ατόμου σε διαγνωστική εξέταση. Παρατηρούμε πως το 90% των συμμετεχόντων κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αξιολόγηση τους.

8. Πόσο καιρό μετά τις πρώτες υποψίες για τη δυσκολία στην ακοή απευθυνθήκατε σε κάποιον ειδικό; ΟΛΟΙ



Ωστόσο, το 82,5% είχε άγνοια σχετικά με τους επαγγελματίες στους οποίους έπρεπε να απευθυνθεί για αυτού του είδους τη διαγνωστική εξέταση. Το 47,5% έλαβε ενημέρωση σχετικά με τις ΔΑΕ και τη διαδικασία εξέτασης από τον λογοθεραπευτή ή τον εργοθεραπευτή με τον οποίο συνεργαζόταν ήδη και το 15% από μη εξειδικευμένο στις ΔΑΕ ΩΡΛ, που παρέπεμψε σε εξειδικευμένο στις ΔΑΕ συνάδελφο.



Όλοι οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για πιθανές δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην πρόσβαση ή την εύρεση ραντεβού για την εξέταση από τον φορέα. Το 52,5% είχε δυσκολίες στην πρόσβαση ή το ραντεβού με ορισμένες απαντήσεις να είναι: «Ναι, η δυσκολία ήταν στη διαδικασία εύρεσης ραντεβού» και «Χρειάστηκαν μήνες για να μας καλέσουν.». Υπάρχουν επανειλημμένα αναφορές στις καθυστερήσεις και τις μεγάλες αναμονές για ραντεβού. Για παράδειγμα, «Ναι, διότι αργήσαμε να βρούμε ραντεβού καθώς αργούσαν να μας απαντήσουν και να μας βρουν ραντεβού στο ΑΧΕΠΑ.».

Για τις απαντήσεις που δηλώνουν ύπαρξη δυσκολιών, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις δυσκολίες σε δύο υποκατηγορίες:

- ο *Δυσκολία στην εύρεση ραντεβού* (π.χ. καθυστερήσεις, χρόνος αναμονής, ανάγκη να επιλέξουν ιδιωτικά ραντεβού λόγω αυξημένων χρόνων αναμονής.)
- ο *Δυσκολία στην πρόσβαση λόγω απόστασης ή άλλων πρακτικών παραμέτρων* (π.χ. μακρινές τοποθεσίες, ταξίδια κ.λπ.)

Από την άλλη πλευρά, το 47,5% απάντησε πως δεν είχε δυσκολίες *(χωρίς δυσκολία στην πρόσβαση ή το ραντεβού)* με ορισμένους να απαντούν: «*Όχι, βρήκαμε αμέσως ραντεβού*», «*Η πρόσβαση ήταν εύκολη, γιατί μέναμε κοντά.*».

Στη συνέχεια, με βάση το γεγονός πως στην Ελλάδα το κόστος για διαγνωστικές εξετάσεις καλύπτεται μόνο σε δημόσιους φορείς (π.χ. νοσοκομεία) και η κάλυψη των θεραπειών γίνεται μέσω ΕΟΠΠΥ, αναφέρεται πως δεν υπάρχει κωδικός που να αντιστοιχεί στη διάγνωση της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας με στόχο την κάλυψη εξόδων αποκατάστασης. Το κενό αυτό αποτυπώνεται και στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις οποίες το 97,5% δεν έλαβε καμία οικονομική ενίσχυση ενώ το 2,5% δεν αναζήτησαν πληροφορίες για το εάν δικαιούνται κάποια κρατική χρηματοδότηση.

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί πως από το 74,1% των ατόμων που μετά τη διαγνωστική εξέταση έλαβαν διάγνωση ΔΑΕ και προχώρησαν στην αποκατάσταση μέσω ακουστικής εκπαίδευσης, το 66,7% αυτών χρησιμοποίησαν τα χρήματα που τους παρείχε το κράτος για άλλα είδη θεραπειών (λογοθεραπεία / εργοθεραπεία) από τις άλλες συνοδές δυσκολίες τους. Το υπόλοιπο 33,3% πλήρωσε την αποκατάσταση ιδιωτικά αναφέροντας

πως το κόστος ήταν μεγάλο και υπήρχαν φορές που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν και σταματούσαν τη θεραπεία χωρίς να την έχουν ολοκληρώσει.

Τέλος, ένα ποσοστό 67,5% από τον συνολικό αριθμό συμμετεχόντων ανέφερε οικονομική δυσκολία λόγω προσβασιμότητας (απόσταση, έξοδα μετακίνησης) διότι η διαγνωστική εξέταση διενεργείται στο νοσοκομείο διαζώσης και έπρεπε να παρευρεθούν.

Η αναγνώριση / αποδοχή της ΔΑΕ από επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας ή της υποστήριξης στο υγειονομικό περιβάλλον ήταν μια από τις ερωτήσεις που δυσκόλεψε τους συμμετέχοντες. Καταμετρήθηκαν οι απαντήσεις μόνο των ατόμων που είχαν λάβει διάγνωση ΔΑΕ και υπολογίζονται ως εξής: το 70,4% θεωρεί ότι είχε την απαραίτητη αποδοχή σε όλους τους τομείς που αναφέρθηκαν και οι απαντήσεις κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών που σχετίζονται με την αναγνώριση ή αποδοχή της ΔΑΕ από διάφορους επαγγελματίες. Από την άλλη πλευρά, το 29,6% νιώθει πως δεν έγινε αποδεκτό από τον περίγυρό τους και πως δεν μπορούσε ο κόσμος αλλά και αρκετοί ειδικοί (χωρίς να προσδιορίζουν ειδικότητες) να αντιληφθεί τα χαρακτηριστικά της διάγνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, από το 70,4% που ανέφερε θετικές εμπειρίες, το 47,5% αναφέρθηκε στον τομέα της εκπαίδευσης λέγοντας πως οι εκπαιδευτικοί αποδέχτηκαν την ύπαρξη της δυσκολίας και έδειξαν ενδιαφέρον να ενημερωθούν και να βοηθήσουν. Επίσης, στην αποδοχή από τους λογοθεραπευτές αναφέρθηκε το 47,37%. Σημαντικός πυλώνας ήταν και η οικογένεια με το 26,32% να αναφέρει πως έλαβε την κατάλληλη αποδοχή από

την άμεση οικογένεια και τα ευρύτερα μέλη της. Τέλος, ένας ενήλικας συμμετέχων ανέφερε πως η λήψη της διάγνωσης του έδωσε την ευκαιρία να αποδεχτεί τον εαυτό του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: *«Έμαθα να με αγαπάω με την δυσκολία μου και να μην θεωρώ πως είμαι παράλογος.»(sic)*

Για το 29,6% που θεωρεί πως δεν έλαβε την αρμόζουσα αποδοχή, το 87,50% αναφέρει πως οι ΩΡΛ που δεν είχαν εξειδίκευση στις ΔΑΕ, δεν αποδέχονταν την ύπαρξη της διάγνωσης. Επίσης, το 62,50% ανέφερε δυσκολίες αποδοχής από το οικογενειακό αλλά και το εργασιακό περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα αναφορικά με την υποστήριξη που έλαβαν τα άτομα που ήταν διαγνωσμένα με ΔΑΕ ήταν αρκετά διαφορετικά καθώς το 44,4% πιστεύει πως έλαβε την κατάλληλη για εκείνο υποστήριξη ενώ το 55,6% πως δεν την έλαβε. Τα ποσοστά συγκριτικά με την εντύπωση των συμμετεχόντων για την αποδοχή ως προς τη διάγνωσή τους δείχνουν μια σημαντική στατιστικά εικόνα, καθώς αποδοχή δέχτηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων με ΔΑΕ, αλλά υποστήριξη έλαβε το μικρότερο ποσοστό.

Από τους 27 συμμετέχοντες που διαγνώστηκαν με ΔΑΕ, το 44,4% απάντησαν «ΝΑΙ» δηλώνοντας ότι έλαβαν υποστήριξη ενώ το 55,6% απάντησαν «ΟΧΙ», δηλώνοντας ότι δεν έλαβαν καμία μορφή υποστήριξης ή ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμοι ειδικοί να τους παρέχουν βοήθεια.

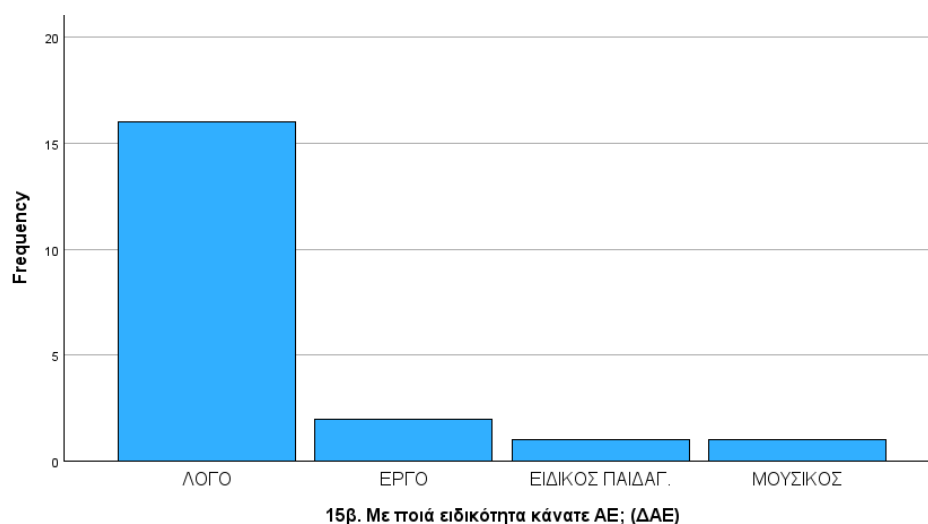
Πιο αναλυτικά, η υποστήριξη που έλαβε το 58,3% των συμμετεχόντων στον χώρο της εκπαίδευσης αναφερόταν στην υποστήριξη από εκπαιδευτικούς. Οι απαντήσεις αφορούσαν τη μετακίνηση του παιδιού σε μπροστινές θέσεις για καλύτερη ακρόαση, υποστήριξη από δασκάλους ένταξης ή παράλληλη στήριξη, ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς που

προσάρμοσαν τη διδασκαλία τους με πιο χαμηλόφωνη ένταση φωνής και υποστήριξη από συγκεκριμένα προγράμματα, όπως στην εκμάθηση αγγλικών μέσω υπολογιστή. Στον χώρο της υγείας αναφέρθηκε το 41,67% των συμμετεχόντων, που ανέφεραν ότι έλαβαν βοήθεια από επαγγελματίες υγείας. Το 33,33% έλαβαν υποστήριξη από λογοθεραπευτές, οι οποίοι προσάρμοσαν τη θεραπευτική παρέμβαση με βάση τη ΔΑΕ και έδωσαν καθοδήγηση για περαιτέρω θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο ενήλικος πληθυσμός που έλαβε διάγνωση ΔΑΕ αναφέρθηκε και στον εργασιακό χώρο με το 8,3% των ενήλικων συμμετεχόντων να αναφέρουν ότι έλαβαν βοήθεια με τη χρήση ωτοασπίδων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή στην εργασία τους, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας.

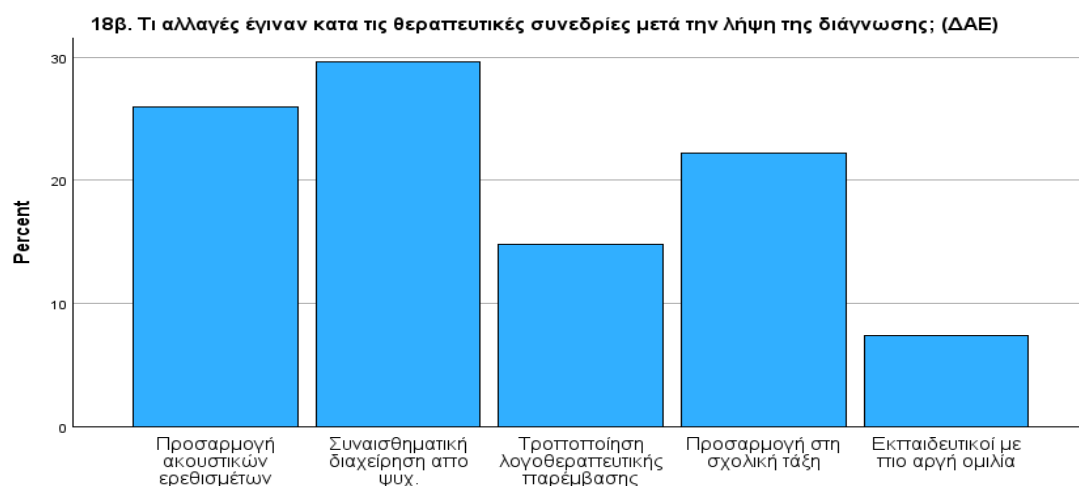
Από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων σε αυτή την ερώτηση αναφέρεται στην έλλειψη υποστήριξης, είτε επειδή οι επαγγελματίες δε γνώριζαν τη διαταραχή είτε επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμες υπηρεσίες στην περιοχή τους. Πιο αναλυτικά, το 60% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι δόθηκαν οδηγίες σε σχολεία ή θεραπευτές, αλλά δεν εφαρμόστηκαν οι προσαρμογές στην πράξη ή αγνοήθηκαν οι οδηγίες που είχαν δοθεί από τον εξειδικευμένο ΩΡΛ.

Συνεχίζοντας, όσο αφορά την αποκατάσταση, γνωρίζουμε πως το 33,3% ανέφερε δυσκολία στην εύρεση κατάλληλου ειδικού που να μπορεί να αναλάβει την ακουστική τους εκπαίδευση, και από το 74,1% που προχώρησαν στην ακουστική εκπαίδευση, το 80% επέλεξε για εκπαιδευτή του κάποιον λογοθεραπευτή, ενώ χαρακτηριστική ήταν η απάντηση μιας μητέρας που

ανέφερε ότι ενήργησε μόνη της κάνοντας ακουστική εκπαίδευση στο σπίτι νομίζοντας πως μπορεί να το υποστηρίξει.



Σε όλες τις περιπτώσεις που τα άτομα παρακολουθούσαν και άλλου είδους θεραπείες για τις συνοδές δυσκολίες τους, μόνο το 33,3% παρατήρησε τροποποίηση στη διεξαγωγή των άλλων συνεδριών τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί από τον εξειδικευμένο ΩΡΛ που πραγματοποίησε τη διαγνωστική εξέταση. Αναφέρθηκαν κυρίως στη συναισθηματική ενίσχυση από ψυχολόγους και στην προσαρμογή ακουστικών ερεθισμάτων (κλειστά παράθυρα, ήπιος τόνος φωνής) και προσαρμογές στη σχολική αίθουσα (μετακίνηση σε θέση μπροστά στον εκπαιδευτικό, μακριά από πόρτες και παράθυρα, γραπτές οδηγίες).



Η καταγραφή και ομαδοποίηση τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών εμπειριών των συμμετεχόντων αποτελεί τον κεντρικό άξονα της παρούσας έρευνας. Οι εμπειρίες (θετικές / αρνητικές) καταγράφηκαν ξεχωριστά για όσους ολοκλήρωσαν τη διαγνωστική εξέταση και η ακουστική τους επεξεργασία ήταν φυσιολογική και για όσους έλαβαν την διάγνωση της ΔΑΕ.

Αναλυτικά, έχουμε τα εξής αποτελέσματα: Για τα άτομα με φυσιολογική ακουστική επεξεργασία (32,5%), οι απαντήσεις για τις αρνητικές εμπειρίες «μοιράστηκαν» καθώς το 46,2% ανέφερε πως είχε αρνητικές εμπειρίες ενώ το 53,8% πως δεν είχε. Ωστόσο, είναι άξιο αναφοράς πως το 61,5% είχαν να αναφέρουν τουλάχιστον μια θετική εμπειρία που να σχετίζεται με την ΔΑΕ ή / και τη διαδικασία εξέτασης.

Στα αποτελέσματα των αρνητικών εμπειριών, έγιναν αναφορές κυρίως στο πλαίσιο διεξαγωγής της διαγνωστικής εξέτασης που έδρευε στο τμήμα ψυχιατρικής και δημιουργούσε άβολα συναισθήματα. Για παράδειγμα: «Υπήρχαν άτομα που φώναζαν και δεν ξέραμε πως να το εξηγήσουμε στο παιδί». Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν οι δυσκολίες για την εύρεση ραντεβού

καθώς και οι μεγάλες αποστάσεις που έπρεπε να διανύσουν για να φτάσουν στο νοσοκομείο. Από την άλλη πλευρά, οι θετικές εμπειρίες σχετίζονταν με τη θετική / παιδαγωγική προσέγγιση του εξειδικευμένου ΩΡΛ και με την ευχάριστη διαδικασία της εξέτασης: *«Είχαμε άγχος πως θα ανταποκριθεί το παιδί αλλά πέρασε όμορφα και της άρεσε η διαδικασία με τα ακουστικά.»*.

Για τους συμμετέχοντες που διαγνώστηκαν με ΔΑΕ, τα ποσοστά δείχνουν μεγάλη διακύμανση ως προς τις εμπειρίες τους συγκριτικά με τα άτομα με φυσιολογική ακουστική επεξεργασία. Πιο συγκεκριμένα, το 51,9% είχε να αναφέρει τουλάχιστον ένα αρνητικό περιστατικό που είχε προκύψει ενώ το 59,3% είχε να αναφέρει τουλάχιστον μια θετική εμπειρία.

Οι αρνητικές εμπειρίες παρουσιάστηκαν ως εξής: από το 51,9% που ανέφερε αρνητικές εμπειρίες το 78,57% ανέφερε ΩΡΛ μη εξειδικευμένους στη ΔΑΕ, οι οποίοι λόγω άγνοιας δεν αποδέχονταν τη διάγνωση της ΔΑΕ, φέρνοντας τους ασθενείς σε δύσκολη θέση. Για παράδειγμα: *«Μας έσκισε το χαρτί και μας είπε ότι αφού μιλάει το παιδί, σημαίνει πως ακούει!»*. Επίσης, το 64,29% αναφέρθηκε στο σχολικό περιβάλλον και σε εκπαιδευτικούς που αδιαφόρησαν για τη διάγνωση και τις δυσκολίες του παιδιού, αναφέροντας και περιστατικά χλευασμού. Σε γενικές κοινωνικές και δημόσιες δυσκολίες αναφέρθηκε ο ενήλικος πληθυσμός με το 21,43% να καταγράφει δυσκολίες στην επικοινωνία, που οδήγησαν σε κοινωνική απομόνωση, ενώ και εδώ το 21,43% από τους συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης και το γεγονός ότι ήταν αγχωτική λόγω ακατάλληλου χώρου (π.χ. ψυχιατρικά τμήματα).

Η ανάλυση των θετικών εμπειριών ανέδειξε πως 60% από τους συμμετέχοντες συναναστράφηκαν επαγγελματίες υγείας & εκπαίδευσης που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν και να εφαρμόσουν προσαρμογές (π.χ. μετακίνηση του παιδιού πιο κοντά στην έδρα, χρήση υποστηρικτικού υλικού). Το 46,67% επεσήμαναν τη θετική συμβολή ειδικών (λογοθεραπευτών, μουσικών, ψυχολόγων), οι οποίοι προσαρμόστηκαν στις ανάγκες τους. Με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ασχολήθηκε το 20% δηλώνοντας πως η διάγνωση και η παρέμβαση βοήθησαν το παιδί να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να μπορεί να επικοινωνεί καλύτερα.

Σε μια προσπάθεια καταγραφής των επιθυμιών των συμμετεχόντων, είτε είχαν ΔΑΕ είτε φυσιολογική ακουστική επεξεργασία αποδεδειγμένη κατόπιν της διαγνωστικής εξέτασης, βλέπουμε πως το 95% των συμμετεχόντων ήταν πρόθυμο να δώσει τις δικές του προτάσεις, ενώ 2 άτομα ανέφεραν πως δε γνώριζαν καθόλου τι θα μπορούσε να βοηθήσει. Πιο αναλυτικά, σχετικά με το τι θα ήθελαν να αλλάξουν ώστε να υποστηριχθούν καλύτερα τα άτομα με ΔΑΕ (για όσους είχαν φυσιολογική ακουστική επεξεργασία, η ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής: *«Με βάση τις αρχικές σας υποψίες και τη διαδικασία στην οποία υποβληθήκατε, τι πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε αν τελικά είχατε διαγνωστεί με ΔΑΕ και τι πιστεύετε θα βοηθούσε τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί;»*) και παρατηρούμε την ανάδειξη των εξής τομέων:

♦ Α. Υγειονομικός Τομέας

Το 77,50% ανέφεραν ότι δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες υγείας επαρκώς ενημερωμένοι για τη ΔΑΕ, ζητώντας βελτίωση στην εκπαίδευσή

τους. Το 50% επισήμαναν την ανάγκη για περισσότερους χώρους διεξαγωγής των διαγνωστικών εξετάσεων, ώστε να περιορισθούν οι αποστάσεις, καθώς και συντομότερα ραντεβού.

◇ Β. Εκπαίδευση

Το 55,5% ζήτησαν ενημέρωση / εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη ΔΑΕ και τους τρόπους υποστήριξης των μαθητών, ενώ το 22,5% πρότεινε την εισαγωγή περισσότερων λογοθεραπευτών στα σχολεία με στόχο τη μείωση του χρόνου εντοπισμού δυσκολιών στα παιδιά. Επιπρόσθετα, το 12,5% ζήτησε τη δημιουργία και την παροχή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με ΔΑΕ που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί κατά την μαθησιακή διαδικασία.

◇ Γ. Ευαισθητοποίηση του Κοινού

Το 75% ανέφεραν την ανάγκη για εκστρατείες ενημέρωσης, ώστε η κοινωνία να μάθει για την ύπαρξη της ΔΑΕ και να περιορισθεί η αμφιβολία και η απομόνωση των ατόμων. Το 55% ζήτησε τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για γονείς ώστε να μάθουν να υποστηρίζουν τα παιδιά τους.

◇ Δ. Εργασιακός Χώρος

Το 12,5% ανέφερε ότι οι εργοδότες δε γνωρίζουν τη ΔΑΕ και δεν παρέχουν προσαρμογές στον εργασιακό χώρο, άρα θα πρέπει να υπάρξουν προγράμματα ενημέρωσης σε εταιρείες και δημόσιους χώρους εργασίας. Το 5% πρότεινε τη δημιουργία ηχομονωμένων χώρων στην εργασία τους.

◇ Ε. Έγκριση Υγειονομικής Επιτροπής Παροχών

Το 90% ζήτησε να προστεθεί κωδικός στον ΕΟΠΠΥ για τη Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας ώστε να καλύπτονται οικονομικά οι θεραπείες. Το 40% ανέφερε ότι η ΔΑΕ πρέπει να ενταχθεί και στο σύστημα ΚΕΠΑ για να λαμβάνουν οικονομική στήριξη και τα ενήλικα άτομα.

Αντίστοιχες απαντήσεις δόθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες και ως προς τους σημαντικότερους τομείς δημόσιας πολιτικής για τη ΔΑΕ. Και οι 40 συμμετέχοντες ανέφεραν τους ίδιους τομείς προτείνοντας ακριβώς τις ίδιες προτάσεις. Τα επιπρόσθετα αποτελέσματα που λάβαμε είναι πως το 40% ζήτησε πιο οργανωμένο σύστημα υγείας με ταχύτερα και περισσότερα ραντεβού (να αναφερθεί πως κατά τη χρονική περίοδο που εξετάζει η παρούσα έρευνα, το τμήμα ψυχοακουστικής δεν ήταν ενεργό όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο αριθμός των ασθενών που μπορούσε να δεχτεί). Επιπλέον, το 35% ζήτησε κρατική επιδότηση θεραπειών και ακουστικών βοηθημάτων. Επίσης, το 25% πρότεινε οι διαγνωστικές εξετάσεις για ΔΑΕ να γίνουν υποχρεωτικές από το κράτος ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη. Αναφέρθηκε από το 22,5% πως τα κοινωνικά δίκτυα και τα ΜΜΕ θα μπορούν να λάβουν ενημέρωση από το κράτος και να προωθήσουν εκστρατείες ενημέρωσης τους κοινού. Τέλος, 2 άτομα ανέφεραν πως στον εργασιακό τομέα θα πρέπει το κράτος να δημιουργήσει νομική προστασία για εργαζομένους με ΔΑΕ ώστε να μπορούν να ζητούν μικρότερα και συχνότερα διαλλείματα ή χώρους αποφόρτισης.

Αφήνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσθέσουν κάποιο δικό τους σχόλιο, αναδείχθηκε μια σειρά από θέματα και προτάσεις

που σχετίζονται με την υποστήριξη των ατόμων με ΔΑΕ και των οικογενειών τους που θα αναλυθούν περιγραφικά στην συζήτηση της παρούσας έρευνας.

3.2 Σύνθεση Συμπερασμάτων και Προτάσεων

Βασισμένα στα ευρήματα από την ανάλυση, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που ανακύπτουν είναι τα εξής:

- *Εκπαίδευση και ενημέρωση:* Πρέπει να υπάρξει συνεχής και στοχευμένη εκπαίδευση για γονείς, εκπαιδευτικούς, θεραπευτές και άλλους ειδικούς για τη Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας. Επιπλέον, το κράτος θα πρέπει να ενισχύσει την ενημέρωση μέσω εκστρατειών και την ενσωμάτωση αυτής της εκπαίδευσης στις σχολικές και υγειονομικές πρακτικές / εκπαιδεύσεις.
- *Υποστήριξη και χρηματοδότηση:* Η οικονομική υποστήριξη για τις οικογένειες είναι ζωτικής σημασίας. Οι πολιτικές υγειονομικής κάλυψης πρέπει να περιλαμβάνουν επιδοτήσεις για θεραπείες, ακουστικά και άλλες αναγκαίες συσκευές. Το κράτος θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε αυτές τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για όλα τα άτομα με ΔΑΕ.
- *Άμεση και προσβάσιμη Διαγνωστική Διαδικασία:* Είναι επιτακτική η ανάγκη να μειωθούν οι αναμονές για διαγνωστικά ραντεβού σε δημόσιους φορείς και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες υγείας, έτσι ώστε τα άτομα με ΔΑΕ να μπορούν να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπεία άμεσα.
- *Κατανόηση και στήριξη στην κοινωνία και τον επαγγελματικό χώρο:* Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινού, καθώς και η

προσαρμογή του εργασιακού και σχολικού περιβάλλοντος για τα άτομα με ΔΑΕ, πρέπει να ενισχυθούν μέσω της ενημέρωσης και της δημιουργίας υποστηρικτικών κοινοτήτων.

Αυτά τα ευρήματα αναδεικνύουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων και μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ΔΑΕ. (βλ. σχεδιάγραμμα 1)

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε τέσσερα βασικά θέματα: την ανάγκη για εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών, την οικονομική υποστήριξη των οικογενειών, την ενημέρωση του κοινού και την ευαισθητοποίηση, καθώς και τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης και διάγνωσης. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της παροχής ολιστικής υποστήριξης στα άτομα με Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) και τις οικογένειές τους. Η συζήτηση αυτών των αποτελεσμάτων είναι κρίσιμη για την κατανόηση των εμπειριών των ατόμων που υποβάλλονται σε διαγνωστική εξέταση για ΔΑΕ και διαγιγνώσκονται με ΔΑΕ ή εν τέλει με φυσιολογική ακουστική επεξεργασία, και μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών αξιολόγησης / διάγνωσης και αποκατάστασης.

4.1. Σύγκριση με τη Βιβλιογραφία

Τα ευρήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών αναδεικνύουν μια σαφή ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, ώστε να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τη ΔΑΕ (Central Auditory Processing Disorder, 2017; Agrawal et al., 2021). Οι Bamiou et al. (2006) υποστηρίζουν

ότι η έλλειψη εξειδίκευσης στους επαγγελματίες συμβάλλει στην καθυστερημένη διάγνωση / γνωμάτευση και υποστήριξη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης πάνω στο αντικείμενο (Agrawal et al., 2021; Bernard et al., 2024). Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις απαντήσεις των συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας, οι οποίοι ζητούν πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση γιατρών και εκπαιδευτικών, γεγονός που δείχνει τη σύνδεση μεταξύ της ελλιπούς εκπαίδευσης και της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας σχετικά με τις Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας.

Οι απαντήσεις στην παρούσα έρευνα υπογραμμίζουν τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες ατόμων με ΔΑΕ, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τους Agrawal et al. (2021). Αυτή η μελέτη αναφέρει ότι η έλλειψη οικονομικής στήριξης είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες αξιολόγησης και θεραπείας. Οι συμμετέχοντες εδώ εκφράζουν συχνά την ανάγκη για επιδοτήσεις και χρηματοδότηση, μια πρόταση που αντανάκλα τη γενικότερη ανάγκη για αυξημένη κρατική υποστήριξη που αναφέρεται και στη βιβλιογραφία.

Η έρευνα αναδεικνύει έντονα την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού, η οποία επισημαίνεται επίσης από τους Bamiou et al. (2015). Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρει ότι η έλλειψη γνώσης γύρω από τη ΔΑΕ μπορεί να οδηγήσει σε στίγμα και απομόνωση των ατόμων που πάσχουν από αυτή. Αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από την έρευνα των Bernard et al., (2024) όσο και από τη δική μας, στην οποία το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ζητούν δημόσιες εκστρατείες ενημέρωσης, κάτι που

ευθυγραμμίζεται με τη βιβλιογραφική πρόταση για την ευρύτερη κατανόηση της διαταραχής ως μέσο για την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης.

Οι συμμετέχοντες της έρευνάς μας ζητούν πιο άμεσες και προσβάσιμες διαδικασίες, μια ανάγκη που συμφωνεί με την κριτική της βιβλιογραφίας για τις υπάρχουσες πρακτικές διάγνωσης. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες αξιολόγησης και διάγνωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν μεγάλες καθυστερήσεις και περίπλοκες διαδικασίες για την εύρεση ειδικών. Αυτό συνδέεται με τα ευρήματα των Agrawal et al. (2021), που περιγράφουν τις ίδιες προκλήσεις για τους ασθενείς κατά την πρόσβαση σε διαγνωστικές υπηρεσίες.

4.2. Ερμηνεία των Ευρημάτων

Η ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και εκπαιδευτικών αποτελεί κεντρικό θέμα τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στην έρευνά μας (Agrawal et al., 2021; Bernard et al., 2024). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση και αναγνώριση της ΔΑΕ, κάτι που ενδέχεται να οφείλεται στην περιορισμένη εκπαίδευση των ειδικών (Agrawal et al., 2021). Πολλές από τις απαντήσεις αναφορικά με την εμπειρίες των συμμετεχόντων αφορούσαν σε επαγγελματίες ΩΡΛ που δεν αποδέχτηκαν τη διάγνωση της ΔΑΕ και θεώρησαν πως η κλινική εικόνα των ατόμων οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Ως αποτέλεσμα αυτών των αντικρουόμενων απόψεων η απόφαση για την έναρξη της ακουστικής εκπαίδευσης αναβλήθηκε. Η έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων για τη διαγνωστική εξέταση και την αποκατάσταση της ΔΑΕ μπορεί

να προκαλέσει καθυστερημένες διαγνώσεις, οδηγώντας σε υποστηρικτικά μέτρα που δεν είναι πάντα επαρκή (Agrawal et al., 2021; Bernard et al., 2024), αλλά και σε λαθεμένες μεθόδους παρέμβασης που θα ταλαιπωρήσουν το άτομο και θα το απομακρύνουν από τον τελικό στόχο που είναι η αποκατάσταση. Αυτή η παρατήρηση συνάδει με τις αναφορές των Bamjiou et al. (2006), οι οποίοι επισημαίνουν ότι η συνεχής επιμόρφωση των επαγγελματιών είναι κρίσιμη για την πρόληψη και την αποτελεσματική παρέμβαση.

Συνολικά, η αποδοχή της ΔΑΕ φαίνεται να εξαρτάται από την ενημέρωση των επαγγελματιών και των ατόμων γύρω από το άτομο με ΔΑΕ, καθώς και από την υποστήριξη που υπάρχει από το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Η έλλειψη οικονομικής υποστήριξης για τα άτομα με ΔΑΕ και τις οικογένειές τους είναι μια επιπλέον πρόκληση, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων και τη βιβλιογραφία. Η δυσκολία να καλυφθούν τα έξοδα για θεραπείες, ακουστικά ή άλλο υποστηρικτικό υλικό καθιστά την κατάσταση των ατόμων με ΔΑΕ ακόμη πιο δύσκολη. Στην Ελλάδα οι ασθενείς βασίζονται οικονομικά από τον δημόσιο φορέα του ΕΟΠΠΥ, ο οποίος χρηματοδοτεί τις συνταγογραφημένες θεραπείες των ασθενών. Στην παρούσα χρονική στιγμή, καθώς δεν υπάρχει κανένας ιατρικός κωδικός στον συγκεκριμένο φορέα για συνταγογράφηση θεραπειών, οι ασθενείς δεν λαμβάνουν καμία οικονομική για βοήθεια για την αποκατάσταση της ΔΑΕ. Η ανάγκη για κρατική οικονομική στήριξη, που αναφέρουν οι συμμετέχοντες, αποτελεί σημαντική ένδειξη για τις υγειονομικές και κοινωνικές ανισότητες που

αντιμετωπίζουν αυτοί οι ασθενείς. Οι Agrawal et al. (2021) συμφωνούν, καταγράφοντας την οικονομική ένδεια ως βασικό φραγμό στην πρόσβαση σε υπηρεσίες αξιολόγησης και θεραπείας.

Η ευαισθητοποίηση του κοινού και η διάδοση πληροφοριών για τη ΔΑΕ είναι ουσιαστική για την καταπολέμηση του στίγματος και της κοινωνικής απομόνωσης των ατόμων με ΔΑΕ. Η έρευνά μας έδειξε ότι οι συμμετέχοντες αισθάνονται συχνά την ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση και πιο ανοιχτό διάλογο γύρω από το θέμα της ΔΑΕ, γεγονός που ενισχύει τη θέση των Bamioy et al. (2015), οι οποίοι υπογραμμίζουν τη σημασία της δημόσιας ενημέρωσης για την εξάλειψη των προκαταλήψεων και την ενίσχυση της υποστήριξης των ατόμων με ΔΑΕ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων, αναφέρθηκε στην πραγματοποίηση μαζικών εκστρατειών που θα βοηθήσει τόσο τους ειδικούς και τους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως το κοινό να αναγνωρίζει, να αποδέχεται και να σέβεται αυτή τη δυσκολία χωρίς σχόλια και κριτική απέναντί τους.

Οι καθυστερήσεις και οι δυσκολίες στις διαγνωστικές δοκιμασίες είναι σημαντικά ευρήματα της έρευνάς μας, τα οποία συνδέονται με τη βιβλιογραφία που υποδεικνύει ότι η διαδικασία διάγνωσης της ΔΑΕ συχνά είναι χρονοβόρα και περίπλοκη. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν έντονα τη δυσφορία τους για τις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση / εξέταση και την έλλειψη κατάλληλης καθοδήγησης, κάτι που περιορίζει την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων. Το 82,5% της έρευνάς μας, μας απάντησε πως δε γνώριζαν σε ποιόν έπρεπε να απευθυνθούν για την δυσκολία τους, αναφέροντας πολλές φορές πως θεωρούσαν πως ήταν παράλογοι και υπερβολικοί ή

επέρριπταν ευθύνες σε άλλες αιτίες. Η γνώση τους για την ύπαρξη της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας ήταν μηδενική. Η ανάγκη για πιο άμεση και αποτελεσματική αξιολόγηση / εξέταση είναι ευθυγραμμισμένη με τα ευρήματα των Agrawal et al. (2021), οι οποίοι σημειώνουν ότι οι καθυστερημένες διαγνώσεις περιορίζουν τις δυνατότητες αποκατάστασης των ατόμων.

Συνολικά, η ερμηνεία των ευρημάτων δείχνει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΕ αφορούν κυρίως τις περιορισμένες γνώσεις των επαγγελματιών, τις οικονομικές δυσκολίες, την ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη και την έλλειψη αποτελεσματικής διαγνωστικής διαδικασίας (Agrawal et al., 2021). Η έλλειψη εξειδικευμένης εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και παιδείας δυσχεραίνει την έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΕ, οδηγώντας συχνά σε καθυστερημένες διαγνώσεις και ανεπαρκή υποστήριξη. Παράλληλα, οι οικονομικοί φραγμοί αποτρέπουν πολλές οικογένειες από το να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας παρεμβάσεις, γεγονός που επιδεινώνει τις ανισότητες στην περίθαλψη. Επιπλέον, η κοινωνική απομόνωση και το στίγμα που συνοδεύουν τη διάγνωση επιβαρύνουν την ψυχολογία των ατόμων αυτών, ενισχύοντας την ανάγκη για ευρύτερη κοινωνική αποδοχή και ένταξη. Αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και οργανωμένη προσέγγιση στην υποστήριξη των ατόμων με ΔΑΕ, που να περιλαμβάνει την εκπαίδευση των επαγγελματιών, την οικονομική στήριξη, τη βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης, αλλά και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και αποδοχής.

4.3. Πρακτικές Εφαρμογές

Η ανάγκη για εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, των εκπαιδευτικών και των θεραπειών σχετικά με τη ΔΑΕ αναδεικνύεται ως καθοριστική. Αυτό συνάδει με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας που υπογραμμίζουν την έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης των επαγγελματιών και την ανάγκη για εξειδίκευση στον τομέα της ΔΑΕ (Dawes et al., 2019; Agrawal et al., 2021). Η εφαρμογή αυτής της πρότασης μπορεί να γίνει μέσω:

1. Εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης για επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τα πρώτα σημάδια της ΔΑΕ και να χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης (Bamiou et al., 2006; Dawes et al., 2019; Agrawal et al., 2021; Bernard et al., 2024; Iliadou et al., 2024).
2. Διοργάνωση σεμιναρίων που να εστιάζουν σε νέες μεθόδους διάγνωσης και αποκατάστασης, και να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης (ολιστικές προσεγγίσεις). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το έργο των Bamiou et al. (2006) αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί πρέπει να εκπαιδεύονται καλύτερα στη διαχείριση και αναγνώριση της ΔΑΕ, καθώς αυτό θα επιταχύνει την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση (Agrawal et al., 2021).

Η έρευνά μας αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερη οικονομική υποστήριξη για τις οικογένειες των ατόμων με ΔΑΕ, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα για θεραπείες και ειδικό εξοπλισμό, όπως ακουστικά. Το έργο των Agrawal et al. (2021), τονίζει την ανάγκη για οικονομική στήριξη, αναφέροντας

ότι πολλές οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν το κόστος της θεραπείας ή της αποκατάστασης. Ορισμένες προτάσεις για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης περιλαμβάνουν:

1. Δημιουργία κρατικών προγραμμάτων επιδότησης για το κόστος των θεραπειών και της αγοράς ακουστικών ή άλλων υποστηρικτικών εργαλείων, όπως προτείνεται από τους Agrawal et al. (2021).
2. Επιδοτήσεις για ειδικές θεραπείες ή εκπαιδευτικά προγράμματα, με στόχο την εξάλειψη των οικονομικών εμποδίων για τις οικογένειες με παιδιά που έχουν ΔΑΕ.

Η ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη ΔΑΕ, υπογραμμίζεται έντονα στην παρούσα έρευνα, και έχει επίσης αναφερθεί σε πολλές μελέτες. Η ανάγκη για εκπαιδευτικές εκστρατείες που να προωθούν τη γνώση γύρω από τη ΔΑΕ είναι σύμφωνη με τους Rosenberg et al. (2019), οι οποίοι τονίζουν ότι οι κοινωνικές προκαταλήψεις και η έλλειψη γνώσης γύρω από τη ΔΑΕ εμποδίζουν τα άτομα να ζητήσουν τη βοήθεια που χρειάζονται. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με:

1. Δημιουργία δημόσιων εκστρατειών ενημέρωσης που να ενημερώνουν το κοινό για τη ΔΑΕ και να ενθαρρύνουν την αποδοχή αυτών των ατόμων στην κοινωνία (Rosenberg et al., 2019).
2. Εκπαιδευτικά προγράμματα για γονείς και δασκάλους, ώστε να ενισχυθεί η αναγνώριση των πρώτων συμπτωμάτων της ΔΑΕ και να μειωθεί το στίγμα γύρω από την πάθηση (Rosenberg et al., 2019).

Η καθυστέρηση στην αναγνώριση της ΔΑΕ, όπως επισημαίνεται στην έρευνά μας, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που συνδέεται με την έλλειψη συστηματικής αξιολόγησης. Οι Bamiou et al. (2015) και Agrawal et al. (2021) σημειώνουν πως η έλλειψη ολοκληρωμένης διαγνωστικής διαδικασίας και η καθυστέρηση στη λήψη διάγνωσης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα κατά την εκπαιδευτική ή επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ΔΑΕ.

4.4. Προτάσεις εφαρμογής

Η απλοποίηση των διαγνωστικών διαδικασιών με την ανάπτυξη γρηγορότερων και πιο προσβάσιμων εργαλείων διάγνωσης, όπως και ο εκσυγχρονισμός των αξιολογικών μεθόδων ώστε να περιλαμβάνουν πιο ολοκληρωμένες και ακριβείς μεθόδους για τη διαγνωστική εξέταση της ΔΑΕ σε μικρές ηλικίες και σε ενήλικες, όπως αναφέρεται από τον Agrawal et al. (2021), θα βοηθούσαν πολύ στον τομέα της αξιολόγησης. Επίσης θα βοηθήσει η δημιουργία πιο ολοκληρωμένων εργαλείων αξιολόγησης, που να συνδυάζουν κλινικές παρατηρήσεις με τεχνολογικά εργαλεία για την καλύτερη διαγνωστική εξέταση / αξιολόγηση και διαχείριση της ΔΑΕ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα άτομα με ΔΑΕ αναφέρουν την ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη και στρατηγικές αποκατάστασης που να εστιάζουν όχι μόνο στην αποκατάσταση της ακοής, αλλά και στην ψυχολογική και συναισθηματική τους ευημερία. Στη βιβλιογραφία, οι Rosenberg et al. (2019) και Bamiou et al. (2015) αναγνωρίζουν την ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη και την ενσωμάτωση στρατηγικών για τη διαχείριση του άγχους και της απομόνωσης που βιώνουν οι ασθενείς με ΔΑΕ.

Σε αυτό το στάδιο, απαραίτητη είναι η συμβουλευτική και η ψυχολογική υποστήριξη για τα άτομα με ΔΑΕ, με στόχο τη διαχείριση του άγχους και τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, όπως και η δημιουργία προγραμμάτων αποκατάστασης που να περιλαμβάνουν στρατηγικές για την κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας.

4.5. Περιορισμοί της Έρευνας

Ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς αυτής της έρευνας είναι το μέγεθος του δείγματος. Η έρευνα βασίστηκε σε έναν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ένα μεγαλύτερο δείγμα θα μπορούσε να προσφέρει πιο αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα σχετικά με τις εμπειρίες ατόμων με ΔΑΕ στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες.

Επίσης, η χρήση αυτό-αναφερόμενων δεδομένων για τη συλλογή πληροφοριών από τους συμμετέχοντες ενδέχεται να οδηγήσει σε υποκειμενικότητα και μεροληψία. Οι συμμετέχοντες μπορεί να παραβλέπουν ή να υπερεκτιμούν τις εμπειρίες τους, ή να εκφράζουν κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις, ειδικά σε ευαίσθητα θέματα όπως οι προσωπικές δυσκολίες και η κοινωνική αποδοχή.

Η παρούσα έρευνα δεν εξέτασε τις υποκείμενες διαταραχές ή τις συννοσηρότητες που ενδέχεται να επηρεάζουν τα άτομα με ΔΑΕ. Η παρουσία άλλων ψυχικών ή αναπτυξιακών καταστάσεων (π.χ. ΔΕΠ-Υ, ΔΑΦ) μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία αξιολόγησης και αποκατάστασης, αλλά δεν εξετάστηκε στον ίδιο βαθμό στην παρούσα μελέτη.

Ενδέχεται να υπάρχει περιορισμένη διαφοροποίηση στις δημογραφικές ομάδες που συμμετείχαν στην έρευνα, γεγονός που μπορεί να έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων προέρχονταν από συγκεκριμένες κοινωνικο-οικονομικές τάξεις ή ηλικιακές ομάδες, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των ευρημάτων σε άλλες δημογραφικές ομάδες.

Αν και χρησιμοποιήθηκαν ακριβείς μέθοδοι ανάλυσης, είναι πιθανόν ότι κάποιοι περιορισμοί στην υποκειμενικότητα της ερμηνείας των δεδομένων να υπήρξαν, κυρίως κατά την κωδικοποίηση και την αναγνώριση θεμάτων από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων βασίζεται σε υποκειμενικές απόψεις, και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρξε μεροληψία κατά τη διαδικασία κωδικοποίησης.

Τέλος, δεν αξιολογήθηκε το χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την πρώτη διαγνωστική εξέταση για ΔΑΕ μέχρι την χορήγηση του ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα μπορεί να ήταν επηρεασμένα ανάλογα με την συναισθηματική κατάσταση των συμμετεχόντων μετά την ολοκλήρωση της διάγνωσης. Πιθανόν τα άτομα που εξετάστηκαν πιο κοντά χρονικά στην έρευνα να ήταν πιο «φορτισμένα» συναισθηματικά, σε αντίθεση με συμμετέχοντες που είχαν αξιολογηθεί αρκετά χρόνια παλαιότερα.

4.6. Συστάσεις για Μελλοντική Έρευνα

Αν και η ΔΑΕ συχνά αναγνωρίζεται και διαγιγνώσκεται σε μικρές ηλικίες, οι ενήλικες με ΔΑΕ παραμένουν περισσότερο καιρό αδιάγνωστοι, και οι διαγνωστικές διαδικασίες για αυτή την ηλικιακή ομάδα χρειάζονται

περισσότερη εστίαση. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εστιάσουν στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων διάγνωσης για ενήλικες (Bamiou et al., 2015). Οι μελέτες αυτές θα μπορούσαν να διερευνήσουν τις διαφορές στις διαγνωστικές ανάγκες παιδιών και ενηλίκων, καθώς και τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά τη διαδικασία της διάγνωσης.

Πολλά από τα ευρήματα της έρευνας αναφέρονται στις επιπτώσεις της ΔΑΕ στην εκπαιδευτική πορεία και την επαγγελματική ζωή των ατόμων. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να επικεντρωθούν στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ΔΑΕ και της μακρόχρονης περιόδου χωρίς διάγνωση. Αυτές οι μελέτες θα μπορούσαν να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η έλλειψη έγκαιρης διάγνωσης και κατάλληλης υποστήριξης επηρεάζει την κοινωνική ένταξη και την επαγγελματική επιτυχία των ατόμων με ΔΑΕ. Μια καλή μεθοδολογία για αυτή την έρευνα θα περιλάμβανε τη χρήση μακροπρόθεσμων παρακολουθήσεων των ατόμων σε διάφορες φάσεις της ζωής τους.

Μια σημαντική κατεύθυνση για μελλοντική έρευνα είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων θεραπευτικών και υποστηρικτικών παρεμβάσεων για τα άτομα με ΔΑΕ. Αυτές οι παρεμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη, θεραπεία ακοής, ακουστική εκπαίδευση και άλλες στρατηγικές. Οι μελέτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σχεδιασμούς τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs) για να αξιολογήσουν ποιες παρεμβάσεις έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνική και ψυχολογική ευημερία των ατόμων με ΔΑΕ.

Με την πρόοδο της τεχνολογίας, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τη χρήση της ως εργαλείου για την υποστήριξη ατόμων με ΔΑΕ. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει πώς οι ψηφιακές εφαρμογές, φορητές συσκευές και άλλες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην διάγνωση, εκπαίδευση και αποκατάσταση των ατόμων με ΔΑΕ. Παράλληλα, η ευχρηστία και η πρόσβαση σε τέτοιες τεχνολογίες για διαφορετικές ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες θα μπορούσε να είναι αντικείμενο μιας ενδιαφέρουσας έρευνας.

Αν και η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι σημαντική, η συστηματική έρευνα για την αποτελεσματικότητα εκστρατειών ενημέρωσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ΔΑΕ είναι απαραίτητη. Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να εξετάσουν τις βέλτιστες στρατηγικές για τη διάχυση της γνώσης και την αποδοχή των ατόμων με ΔΑΕ στην κοινωνία, καθώς και να αναλύσουν τον αντίκτυπο αυτών των στρατηγικών στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ευημερίας των ατόμων με τη διαταραχή (Rosenberg et al., 2019).

5. Συμπεράσματα

Η παρούσα έρευνα εστίασε στις εμπειρίες ατόμων με Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και αποκατάστασης, προσφέροντας σημαντικά ευρήματα που συμβάλλουν στην κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Ένα από τα κύρια ευρήματα είναι η ανάγκη για εξειδικευμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας και εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις περιπτώσεις της ΔΑΕ (Bernard et

al., 2024). Η ανεπάρκεια στην εκπαίδευση αυτών των επαγγελματιών οδηγεί συχνά σε καθυστερήσεις στη λήψη διάγνωσης και στην παροχή υποστήριξης, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη των ατόμων με τη διαταραχή.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη για οικονομική στήριξη, καθώς πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος των απαιτούμενων θεραπειών και εξοπλισμού. Οι οικονομικές δυσχέρειες επιδεινώνουν το ήδη δύσκολο έργο της αποκατάστασης και ενισχύουν την ανάγκη για κρατική παρέμβαση, μέσω επιδοτήσεων ή παροχής δωρεάν υπηρεσιών.

Επιπλέον, η έρευνα τόνισε τη σημασία της έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης, μέσω μιας εξορθολογισμένης και αποδοτικής διαγνωστικής διαδικασίας. Η υποχρεωτική εισαγωγή προληπτικών τυποποιημένων εξετάσεων για την ανίχνευση της ΔΑΕ θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την πρόγνωση, επιτρέποντας την έγκαιρη παρέμβαση. Η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και η καταπολέμηση των προκαταλήψεων γύρω από τη ΔΑΕ είναι επίσης κρίσιμες για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

Οι πρακτικές εφαρμογές των ευρημάτων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες, την παροχή επιδοτήσεων σε οικογένειες, καθώς και την ενίσχυση των δομών υποστήριξης στο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Οι συστάσεις για μελλοντική έρευνα περιλαμβάνουν τη διενέργεια μακροχρόνιων μελετών που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα των διάφορων παρεμβάσεων, καθώς και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην αποκατάσταση της ΔΑΕ.

Τέλος, οι περιορισμοί της έρευνας, όπως το μικρό και γεωγραφικά περιορισμένο δείγμα, υπογραμμίζουν την ανάγκη για ευρύτερες και πιο αντιπροσωπευτικές μελέτες, που θα επιτρέψουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. Παρά τους περιορισμούς, η έρευνα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της διάγνωσης και της υποστήριξης των ατόμων με ΔΑΕ.

6. Βιβλιογραφία

1. American Academy of Audiology (AAA), 2010. Guidelines for Auditory Processing Disorder.
2. Agrawal, D., Dritsakis, G., Mahon, M., M., M., Mountjoy, A., & Bamiou, D. E. (2021). Experiences of Patients with Auditory Processing Disorder in Getting Support in Health, Education, and Work Settings: Findings from an Online Survey. *Frontiers in Neurology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.607907>.
3. Alanazi, A. A. (2023). Understanding Auditory Processing Disorder: A Narrative Review. *Saudi Journal of Medicine & Medical Sciences*, 11(4), 275. https://doi.org/10.4103/sjmms.sjmms_218_23.
4. Bamiou, D.-E., Campbell, N., & Sirimanna, T. (2006). Management of auditory processing disorders. *Audiological Medicine*, 4(1), 46–56. <https://doi.org/10.1080/16513860600630498>.
5. Bamiou, D.-E., Iliadou, V. V., Zanchetta, S., & Spyridakou, C. (2015). What Can We Learn about Auditory Processing from Adult Hearing Questionnaires? *Journal of the American Academy of Audiology*, 26(10), 824–837. <https://doi.org/10.3766/jaaa.15009>.
6. Banumathi, & Jain, C. (2023). A systematic review of auditory processing abilities in children with speech sound disorders. *Journal of Hearing Science*, 13(2), 9–15. <https://doi.org/10.17430/jhs/167384>.

7. Bellis, T. J., & Bellis, J. D. (2015). Central auditory processing disorders in children and adults. *The Human Auditory System - Fundamental Organization and Clinical Disorders*, 129, 537–556. <https://doi.org/10.1016/b978-0-444-62630-1.00030-5>.
8. Bernard, M. W., Nehzat Koohi, & Doris-Eva Bamiou. (2024). Auditory processing disorder: an online survey of hearing healthcare professionals' knowledge and practices. *International Journal of Audiology*, 1–10. <https://doi.org/10.1080/14992027.2024.2321155>.
9. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
10. Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>.
11. British Society of Audiology (BSA), 2011. APD Diagnostic Guidelines.
12. Cacace, A. T., & McFarland, D. J. (1998). Central Auditory Processing Disorder in School-Aged Children. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 41(2), 355–373. <https://doi.org/10.1044/jslhr.4102.355>.
13. Cacace, A. T., & McFarland, D. J. (2009). *Controversies in central auditory processing disorder*. Plural Publishing.

14. Cameron, S., & Dillon, H. (2008). The Listening in Spatialized Noise–Sentences Test (LISN-S): Comparison to The Prototype Lisn and Results from Children with Either a Suspected (Central) Auditory Processing Disorder or a Confirmed Language Disorder. *Journal of the American Academy of Audiology*, 19(05), 377–391. <https://doi.org/10.3766/jaaa.19.5.2>.
15. Central Auditory Processing Disorder. (2022). Asha.org. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/central-auditory-processing-disorder/?srsltid=AfmBOora3GGrUtEx4m4cbdPLUkM9Zs7Ee5gAL0CA0fjm_jz6_EA7tZyF.
16. Chermak, G. D., & Musiek, F. E. (1997). *Central Auditory Processing Disorders*. Singular.
17. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf.
18. Dawes, P., & Bishop, D. (2009). Auditory processing disorder in relation to developmental disorders of language, communication and attention: a review and critique. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 44(4), 440–465. <https://doi.org/10.1080/13682820902929073>.

19. Dawes, P., & Bishop, D. V. M. (2010). Psychometric profile of children with auditory processing disorder and children with dyslexia. *Archives of Disease in Childhood*, 95(6), 432–436. <https://doi.org/10.1136/adc.2009.170118>.
20. DeBonis, D. A. (2015). It Is Time to Rethink Central Auditory Processing Disorder Protocols for School-Aged Children. *American Journal of Audiology*, 24(2), 124–136. https://doi.org/10.1044/2015_aja-14-0037.
21. Del Zoppo, C., Sanchez, L., & Lind, C. (2014). A long-term follow-up of children and adolescents referred for assessment of auditory processing disorder. *International Journal of Audiology*, 54(6), 368–375. <https://doi.org/10.3109/14992027.2014.972523>.
22. Dillon, H., & Cameron, S. (2021). Separating the Causes of Listening Difficulties in Children. *Ear & Hearing*, Publish Ahead of Print. <https://doi.org/10.1097/aud.0000000000001069>.
23. Emanuel, D. C., Ficca, K. N., & Korczak, P. (2011). Survey of the Diagnosis and Management of Auditory Processing Disorder. *American Journal of Audiology*, 20(1), 48–60. [https://doi.org/10.1044/1059-0889\(2011/10-0019\)](https://doi.org/10.1044/1059-0889(2011/10-0019)).
24. Flanagan, S., Zorilă, T.-C., Stylianou, Y., & Moore, B. C. J. (2018). Speech Processing to Improve the Perception of Speech in Background Noise for Children with Auditory Processing Disorder and Typically Developing Peers. *Trends in Hearing*, 22, 233121651875653. <https://doi.org/10.1177/2331216518756533>.

25. Geffner, D. S., & Ross-Swain, D. (2019). Auditory processing disorders: assessment, management, and treatment. Plural Publishing, Inc.
26. Gertsovski, A., & Ahissar, M. (2022). Reduced Learning of Sound Categories in Dyslexia Is Associated with Reduced Regularity-Induced Auditory Cortex Adaptation. *The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 42(7), 1328–1342. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1533-21.2021>.
27. Groves, B. W., Price, J. H., Olsson, R. H., & King, K. A. (1997). Response Rates to Anonymous versus Confidential Surveys. *Perceptual and Motor Skills*, 85(2), 665–666. <https://doi.org/10.2466/pms.1997.85.2.665>.
28. Gyldenkærne, P., Dillon, H., Sharma, M., & Purdy, S. C. (2014). Attend to This: The Relationship between Auditory Processing Disorders and Attention Deficits. *Journal of the American Academy of Audiology*, 25(7), 676–687. <https://doi.org/10.3766/jaaa.25.7.6>.
29. Heine, C., & Slone, M. (2008). The Impact of Mild Central Auditory Processing Disorder on School Performance During Adolescence. *Journal of School Health*, 78(7), 405–407. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2008.00321.x>.
30. Hrastinski, I., Bonetti, A., & Mladen Hedjeve. (2023). Relationship between auditory processing skills and academic achievement of elementary school children. *Specijalna Edukacija I Rehabilitacija*, 22(2), 95–116. <https://doi.org/10.5937/specedreh22-37415>.

31. Iliadou, V. (Vivian), Chermak, G. D., Bamiou, D.-E., Rawool, V. W., Ptok, M., Purdy, S., Jutras, B., Moncrieff, D., Stokkerei Mattsson, T., Ferre, J. M., Fox, C., Grech, H., Geffner, D., Hedjeve, M., Bellis, T. J., Nimatoudis, I., Eleftheriadis, N., Pedersen, E. R., Weihing, J., & Guillory, L. (2018). Letter to the Editor: An Affront to Scientific Inquiry Re: Moore, D. R. (2018) Editorial: Auditory Processing Disorder, *Ear Hear*, 39, 617–620. *Ear & Hearing*, 39(6), 1236–1242. <https://doi.org/10.1097/aud.0000000000000644>.
32. Iliadou, V. (Vivian), Ptok, M., Grech, H., Pedersen, E. R., Brechmann, A., Deggouj, N., Kiese-Himmel, C., Śliwińska-Kowalska, M., Nickisch, A., Demanez, L., Veuillet, E., Thai-Van, H., Sirimanna, T., Callimachou, M., Santarelli, R., Kuske, S., Barajas, J., Hedjeve, M., Konukseven, O., & Veraguth, D. (2017). A European Perspective on Auditory Processing Disorder-Current Knowledge and Future Research Focus. *Frontiers in Neurology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00622>.
33. Iliadou, V. V., Bamiou, D.-E., Sidiras, C., Moschopoulos, N. P., Tsolaki, M., Nimatoudis, I., & Chermak, G. D. (2017). The Use of the Gaps-In-Noise Test as an Index of the Enhanced Left Temporal Cortical Thinning Associated with the Transition between Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease. *Journal of the American Academy of Audiology*, 28(05), 463–471. <https://doi.org/10.3766/jaaa.16075>.

34. Iliadou, V., & Bamiou, D. E. (2012). Psychometric Evaluation of Children with Auditory Processing Disorder (APD): Comparison with Normal-Hearing and Clinical Non-APD Groups. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 55(3), 791–799. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2011/11-0035\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2011/11-0035)).
35. Iliadou, V., Bamiou, D.-E., Kaprinis, S., Kandyli, D., & Kaprinis, G. (2009). Auditory Processing Disorders in children suspected of Learning Disabilities—A need for screening? *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 73(7), 1029–1034. <https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2009.04.004>.
36. Iliadou, V., & Kiese-Himmel, C. (2018). Common Misconceptions Regarding Pediatric Auditory Processing Disorder. *Frontiers in Neurology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00732> Iliadou, V., Moschopoulos, N., Sidiras, C., Eleftheriadou, A., & Nimatoudis, I. (2018). Over-diagnosis of cognitive deficits in psychiatric patients may be the result of not controlling hearing sensitivity and auditory processing. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 72(9), 742–742. <https://doi.org/10.1111/pcn.12768>.
37. Ηλιάδου, Β. (2015). ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΑΕ). Politeianet.gr. <https://www.politeianet.gr/books/9789606796753-iliadou-basiliki-methexis-diataraches-akoustikis-epexergasias-dae-317071>.

38. Ismen, K., & Emanuel, D. C. (2023). Auditory Processing Disorder: Protocols and Controversy. *American Journal of Audiology*, 32(3), 614–639. https://doi.org/10.1044/2023_aja-23-00035.
39. Katz, J., & Tillery, K. L. (2005). Can Central Auditory Processing Tests Resist Supramodal Influences? *American Journal of Audiology*, 14(2), 124–127. [https://doi.org/10.1044/1059-0889\(2005/013\)](https://doi.org/10.1044/1059-0889(2005/013)).
40. Keith, R. W. (1999). Clinical Issues in Central Auditory Processing Disorders. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 30(4), 339–344. <https://doi.org/10.1044/0161-1461.3004.339>.
41. Κουκουβέτσου, Μ. (2020). Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας σε παιδιά και εφήβους. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 8, 567. <https://doi.org/10.12681/edusc.2702>.
42. Kreisman, N. V., John, A. B., Kreisman, B. M., Hall, J. W., & Crandell, C. C. (2012). Psychosocial Status of Children with Auditory Processing Disorder. *Journal of the American Academy of Audiology*, 23(03), 222–233. <https://doi.org/10.3766/jaaa.23.3.8>.
43. Lagacé J., Jutras B., & Gagné J.-P. (2010). Auditory Processing Disorder and Speech Perception Problems in Noise: Finding the Underlying Origin. *American Journal of Audiology*, 19(1), 17–25. [https://doi.org/10.1044/1059-0889\(2010/09-0022\)](https://doi.org/10.1044/1059-0889(2010/09-0022)).
44. Lin, F. R., Ferrucci, L., Metter, E. J., An, Y., Zonderman, A. B., & Resnick, S. M. (2011). Hearing loss and cognition in the Baltimore

- Longitudinal Study of Aging. *Neuropsychology*, 25(6), 763–770.
<https://doi.org/10.1037/a0024238>.
45. Lotfi, Y., Moossavi, A., Afshari, P. J., Bakhshi, E., & Sadjedi, H. (2020). Spectro-temporal modulation detection and its relation to speech perception in children with auditory processing disorder. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 131, 109860.
<https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2020.109860>.
46. Ludwig, A. A., Zeug, M., Schönwiesner, M., Fuchs, M., & Meuret, S. (2019). Auditory localization accuracy and auditory spatial discrimination in children with auditory processing disorders. *Hearing Research*, 377, 282–291.
<https://doi.org/10.1016/j.heares.2019.04.009>.
47. McFarland, D. J., & Cacace, A. T. (2003). Potential problems in the differential diagnosis of (central) auditory processing disorder (CAPD or APD) and attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). *Journal of the American Academy of Audiology*, 14(5), 278–280; author reply 280. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12956312/>.
48. Messersmith, J. J., Entwisle, L., Warren, S., & Scott, M. (2019). Clinical Practice Guidelines: Cochlear Implants. *Journal of the American Academy of Audiology*, 30(10), 827–844.
<https://doi.org/10.3766/jaaa.19088>.
49. Miller, C. A. (2011). Auditory Processing Theories of Language Disorders: Past, Present, and Future. *Language, Speech, and*

- Hearing Services in Schools, 42(3), 309–319.
[https://doi.org/10.1044/0161-1461\(2011/10-0040\)](https://doi.org/10.1044/0161-1461(2011/10-0040)).
50. Moore, D. R. (2011). The Diagnosis and Management of Auditory Processing Disorder. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 42(3), 303–308. [https://doi.org/10.1044/0161-1461\(2011/10-0032\)](https://doi.org/10.1044/0161-1461(2011/10-0032)).
51. Moore, D. R. (2012). Listening difficulties in children: Bottom-up and top-down contributions. *Journal of Communication Disorders*, 45(6), 411–418. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2012.06.006>.
52. Moore, D. R., Ferguson, M. A., Edmondson-Jones, A. M., Ratib, S., & Riley, A. (2010). Nature of Auditory Processing Disorder in Children. *PEDIATRICS*, 126(2), e382–e390.
<https://doi.org/10.1542/peds.2009-2826>.
53. Moore, D. R., Ferguson, M. A., Halliday, L. F., & Riley, A. (2008). Frequency discrimination in children: Perception, learning and attention. *Hearing Research*, 238(1-2), 147–154.
<https://doi.org/10.1016/j.heares.2007.11.013>.
54. Moore, D. R., & Hunter, L. L. (2013). Auditory processing disorder (APD) in children: A marker of neurodevelopmental syndrome. *Hearing, Balance and Communication*, 11(3), 160–167.
<https://doi.org/10.3109/21695717.2013.821756>.
55. Moore, D., Sieswerda, S. L., Grainger, M. M., Bowling, A. R., Nicholette Heim Smith, Perdew, A., Eichert, S., Alston, S., Hilbert,

- L., Summers, L., Lin, L., & Hunter, L. L. (2017). Referral and Diagnosis of Developmental Auditory Processing Disorder in a Large, United States Hospital-Based Audiology Service. *Journal of the American Academy of Audiology*, 29(05), 364–377. <https://doi.org/10.3766/jaaa.16130>.
56. Mountjoy, A. (2021). Auditory Processing Disorder (APD). In Jessica Kingsley Publishers eBooks. <https://doi.org/10.5040/9781805015406>.
57. Musiek, F. E., & Baran, J. A. (2020). The auditory system anatomy, physiology, and clinical correlates. San Diego, Ca Plural Publishing Inc.
58. Musiek, F. E., & Chermak, G. D. (2014a). Handbook of central auditory processing disorder. Plural Publishing.
59. Musiek, F. E., & Chermak, G. D. (2014b). Handbook of central auditory processing disorder. Plural Publishing.
60. Nagao, K., Riegner, T., Padilla, J., Greenwood, L. A., Loson, J., Zavala, S., & Morlet, T. (2016). Prevalence of Auditory Processing Disorder in School-Aged Children in the Mid-Atlantic Region. *Journal of the American Academy of Audiology*, 27(9), 691–700. <https://doi.org/10.3766/jaaa.15020>.
61. Nkyekyer, J., Meyer, D., Pipingas, A., & Reed, N. (2019). The cognitive and psychosocial effects of auditory training and hearing

- aids in adults with hearing loss. *Clinical Interventions in Aging*, Volume 14, 123–135. <https://doi.org/10.2147/cia.s183905>.
62. Phillips, D. P. (2002). Central Auditory System and Central Auditory Processing Disorders: Some Conceptual Issues. *Seminars in Hearing*, 23(4), 251–262. <https://doi.org/10.1055/s-2002-35875>.
63. Purdy, S., & Keith, W. (2014). Assistive and Therapeutic Effects of Amplification for Auditory Processing Disorder. *Seminars in Hearing*, 35(01), 027–038. <https://doi.org/10.1055/s-0033-1363522>.
64. Riccig, C. A., & Hynd, G. W. (1996). Relationship between ADHD and Central Auditory Processing Disorder. *School Psychology International*, 17(3), 235–252. <https://doi.org/10.1177/0143034396173001>.
65. Rosenberg Center. (2017, March 20). rosenbergcenter.com. <https://rosenbergcenter.com/blog/2017/?page=4>.
66. RW, K. (2023). Development and standardization of SCAN-C Test for Auditory Processing Disorders in Children. *Journal of the American Academy of Audiology*, 11(8). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11012239/>.
67. Samara, M., Thai-Van, H., M. Ptok, Glarou, E., E. Veuillet, Miller, S., Pierre Claude Reynard, Grech, H., Nattawan Utoomprurkporn, Afroditi Sereti, Doris-Eva Bamiou, & Vasiliki Vivian Iliadou. (2023). A systematic review and metanalysis of questionnaires used for

- auditory processing screening and evaluation. *Frontiers in Neurology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fneur.2023.1243170>.
68. Sharma, M., Dhamani, I., Leung, J., & Carlile, S. (2014). Attention, Memory, and Auditory Processing in 10- to 15-Year-Old Children with Listening Difficulties. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 57(6), 2308–2321. https://doi.org/10.1044/2014_jslhr-h-13-0226.
69. Sharma, M., Purdy, S. C., & Kelly, A. S. (2009). Comorbidity of auditory processing, language, and reading disorders. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research: JSLHR*, 52(3), 706–722. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2008/07-0226\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2008/07-0226)).
70. Teri James Bellis. (2015). *Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting: from science to practice*. Plural Publishing Inc.
71. Tomlin, D., Dillon, H., Sharma, M., & Rance, G. (2015). The Impact of Auditory Processing and Cognitive Abilities in Children. *Ear & Hearing*, 36(5), 527–542. <https://doi.org/10.1097/aud.0000000000000172>.
72. Vander Werff, K. R., & Burns, K. S. (2011). Brain Stem Responses to Speech in Younger and Older Adults. *Ear & Hearing*, 32(2), 168–180. <https://doi.org/10.1097/aud.0b013e3181f534b5>.
73. Vasiliki Maria Iliadou, Doris-Eva Bamiou, Keith, W., Purdy, S. C., & Thai-Van, H. (2024). It is time to change the way we think about

hearing evaluation. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology/European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck. <https://doi.org/10.1007/s00405-024-08620-1>.

74. Vermiglio, A. J., Velappan, K., Heeke, P., Bulla, E., Fang, X., Bonilla, E., Garner, E., & Skinner, J. (2019). The relationship between speech recognition in noise and non-speech recognition in noise test performances: Implications for central auditory processing disorders testing. *Journal of Communication Disorders*, 77, 31–43. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2018.12.004>.

75. W, J. (2014). Auditory Processing Disorders: An Overview of Current Research James W. Hall III. *Audiology Online*. <https://www.audiologyonline.com/articles/auditory-processing-disorders-overview-current-12703>.

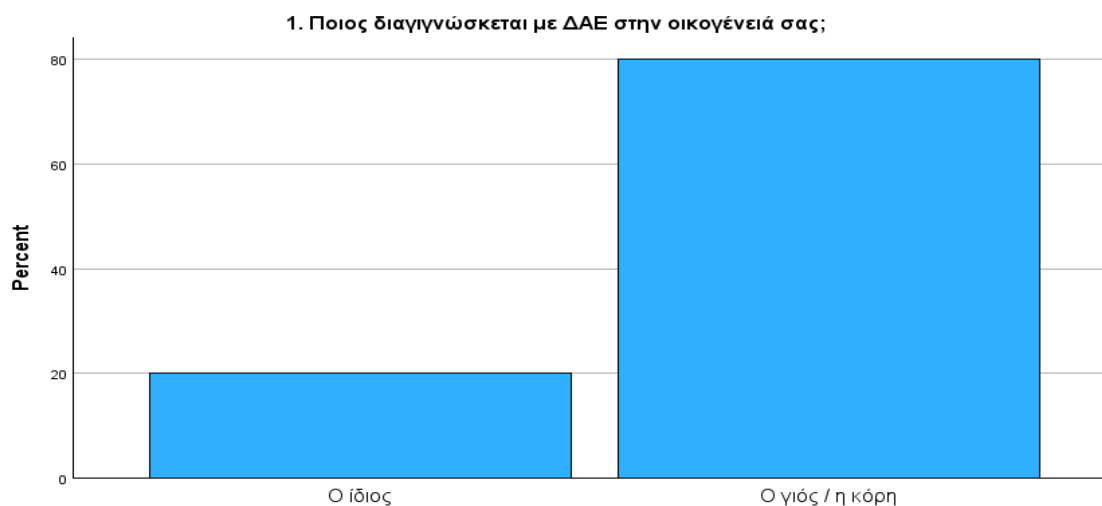
76. Wilson, W. J., & Arnott, W. (2013). Using Different Criteria to Diagnose (Central) Auditory Processing Disorder: How Big a Difference Does It Make? *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 56(1), 63–70. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2012/11-0352\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2012/11-0352)).

Περιεχόμενα:

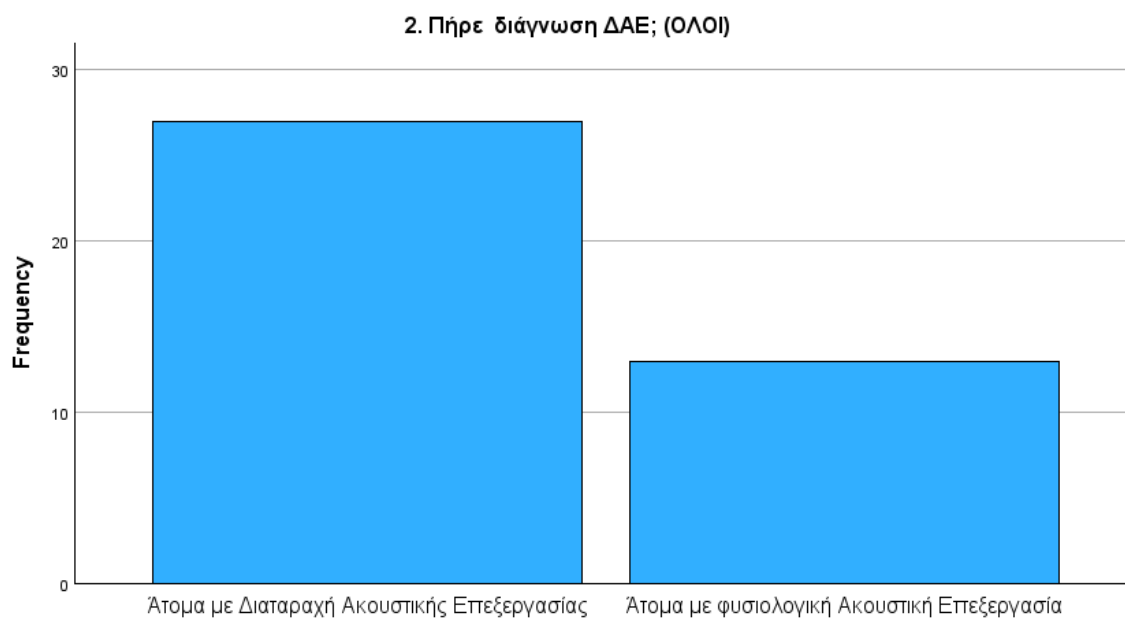
1. Εισαγωγή	
1.1. Ορισμός Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας.....	8
1.2. Συμπτωματολογία της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας.....	10
1.3. Διάγνωση της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας.....	13
1.4. Αποκατάσταση της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας.....	14
1.5.Βιβλιογραφική ανασκόπηση των εμπειριών ασθενών με ΔΑΕ.....	16
2. Υλικό και Μεθοδολογία	
2.1. Συμμετέχοντες.....	19
2.2. Υλικό.....	21
2.3. Διαδικασία.....	22
2.4. Στατιστική Ανάλυση.....	24
3. Αποτελέσματα	
3.1. Ανάπτυξη των Θεμάτων με Παραδείγματα από τα Δεδομένα.....	24
3.2. Σύνθεση Συμπερασμάτων και Προτάσεις.....	37
4. Συζήτηση	
4.1. Σύγκριση με την βιβλιογραφία.....	39
4.2.Ερμηνεία ευρημάτων.....	41
4.3. Πρακτικές εφαρμογές.....	43
4.4. Προτάσεις εφαρμογής.....	47
4.4. Περιορισμοί στην έρευνα.....	48
4.5. Συστάσεις για μελλοντική έρευνα.....	49
5. Συμπεράσματα.....	51
6. Βιβλιογραφία.....	54
7. Παράρτημα- Κατάλογος Πινάκων / Σχεδιαγραμμάτων.....	69

7. Παραρτήματα- Κατάλογος Πινάκων / Σχεδιαγραμμάτων

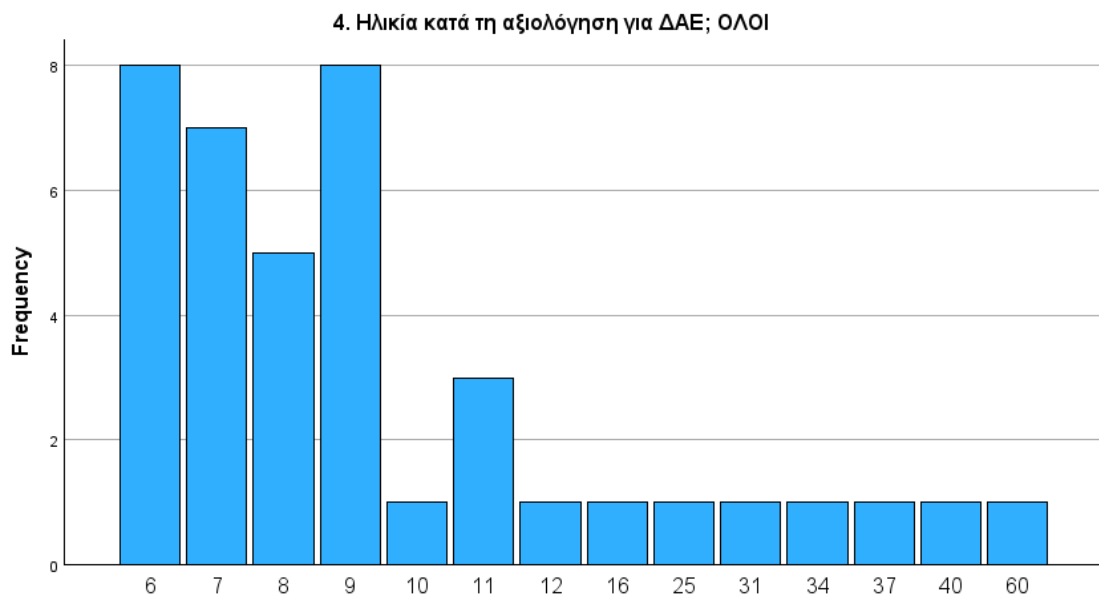
1. Σχεδιάγραμμα ερ.1- Ποιοι συμμετέχοντες διαγνώστηκαν με Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας



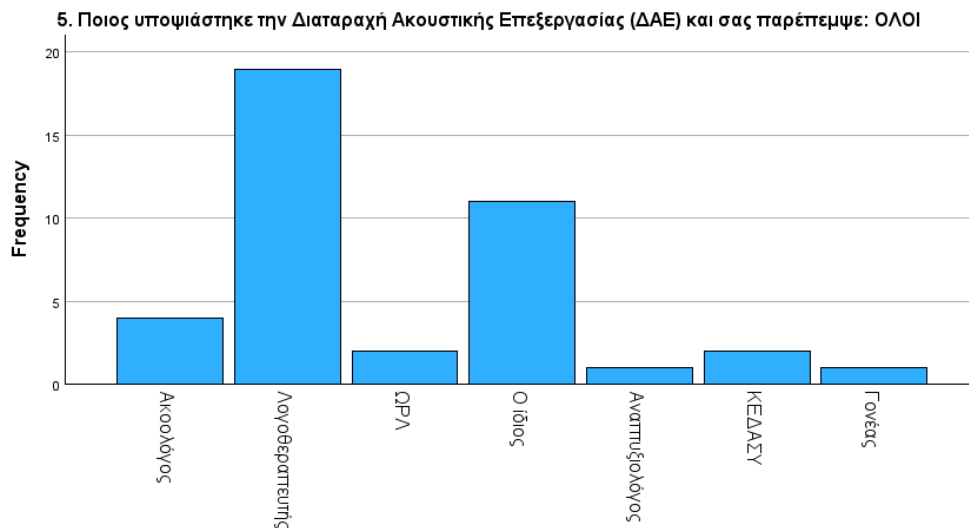
2. Σχεδιάγραμμα ερ.2 - Πόσα άτομα έλαβαν διάγνωση για ΔΑΕ, με βάση τα κριτήρια του European Consensus (Iliadou et al. 2017).



3. Σχεδιάγραμμα ερ.4- Ηλικία κατά την διαγνωστική εξέταση για την ακουστική επεξεργασία με βάση τα κριτήρια του European Consensus (Iliadou et al. 2017) των συμμετεχόντων με ΔΑΕ.

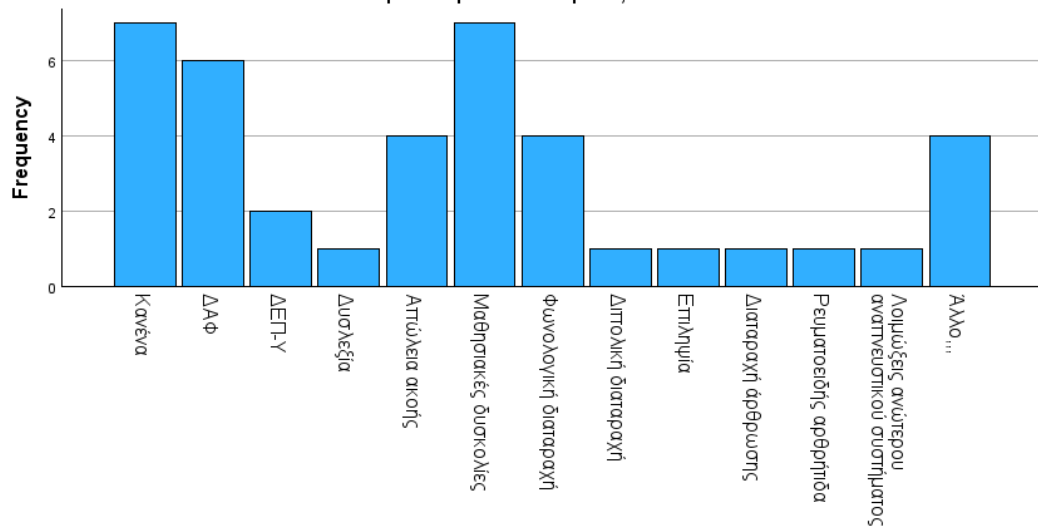


4. Σχεδιάγραμμα ερ.5- Ποιος αντιλήφθηκε την παρουσία συμπτωμάτων ΔΑΕ.



5. Σχεδιάγραμμα / πίνακας ερ.7- Ύπαρξη πρόσθετων αναπηριών, ιατρικών ή άλλων αναγκών των συμμετεχόντων.

7. Έχετε εσείς / το μέλος της οικογένειάς σας με ΔΑΕ, οποιαδήποτε άλλη διάγνωση πρόσθετων αναπηριών, ιατρικών ή άλλων αναγκών; ΟΛΟΙ



6. Πίνακας ερ.8- Πόσο καιρό μετά τις πρώτες υποψίες απευθύνθηκαν σε κάποιον ειδικό;

8. Πόσο καιρό μετά τις πρώτες υποψίες για την δυσκολία στην ακοή απευθυνθήκατε σε κάποιον ειδικό; ΟΛΟΙ

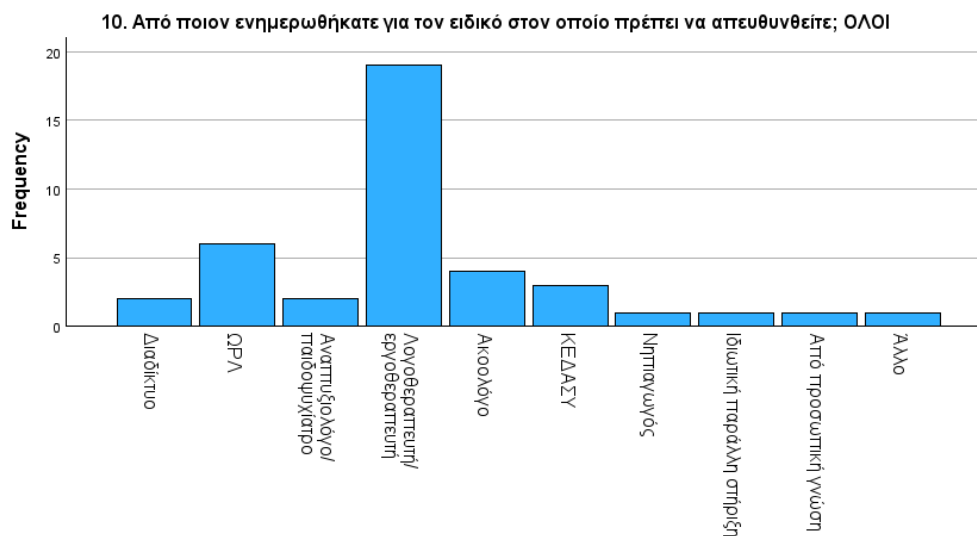
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 μήνα- 6 μήνες	36	90,0	90,0	90,0
	6 μήνες- 1 χρόνο	2	5,0	5,0	95,0
	1 χρόνο- περισσότερο	2	5,0	5,0	100,0

7. Πίνακας ερ.9- Γνώριζαν οι συμμετέχοντες που να απευθυνθούν για την αξιολόγηση / εξέταση και αποκατάσταση;

9. Μετά τις πρώτες υποψίες, γνωρίζατε απο μόνοι σας, που ακριβώς πρέπει να απευθυνθείτε για αξιολόγηση και αποκατάσταση της δυσκολίας σας;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΝΑΙ	7	17,5	17,5	17,5
	ΟΧΙ	33	82,5	82,5	100,0

8. Σχεδιάγραμμα ερ.10- Από ποιον ενημερώθηκαν για τον ειδικό που πρέπει να απευθυνθούν.



9. Πίνακας ερ.11- Δυσκολίες στην εύρεση ραντεβού ή στην πρόσβαση;

11. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στην εύρεση ραντεβού ή στην πρόσβαση;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	NAI	21	52,5	52,5	52,5
	OXI	19	47,5	47,5	100,0

10. Πίνακας ερ.12- Δυσκολίες στην λήψη χρηματοδότησης;

12. Είχατε δυσκολία στην λήψη χρηματοδότησης;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Ci
Valid	Δεν δικαιούμαστε χρήματα για την ΔΑΕ	39	97,5	97,5	
	Δεν το ψάξαμε	1	2,5	2,5	

11. Πίνακας – Ανάλυση ερωτήσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ Σύνοψη των ερωτήσεων που τέθηκαν στο ερωτηματολόγιο με 1. τους αντίστοιχους αριθμούς ερωτήσεων.	
Ερωτήσεις 1-7	Δημογραφικές πληροφορίες
Ερωτήσεις 8-14	Δυσκολίες κατά την λήψη υπηρεσιών και υποστήριξη
Ερωτήσεις 15-18	Λήψη αποκατάστασης και τροποποιήσεις περιβάλλοντος
Ερωτήσεις 19-20	Αρνητικές (19) και θετικές (20) εμπειρίες με επαγγελματίες, οικογένεια και κοινό
Ερωτήσεις 21-22	Συστάσεις για αλλαγή και έρευνα
Ερώτηση 23	Τελικός σχολιασμός

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (1): Υποτομείς που προσδιορίστηκαν σε καθέναν από τους 4 προκαθορισμένους τομείς, απεικονίζοντας τις εμπειρίες των ατόμων με διάγνωση APD και των οικογενειών τους που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη.

